



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN PELAYANAN
INSTALASI FARMASI**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi

Disusun oleh :
Kepala Instalasi Farmasi



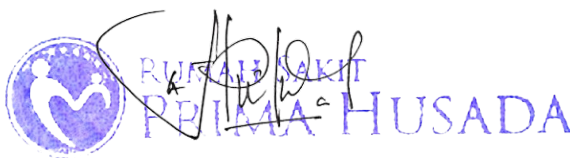
(apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RS Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS Prima Husada.

Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RS Prima Husada Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RS Prima Husada Tahun 2025 ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 30 Mei 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI

1. dr. Nur Mazidah
2. Putri Indah Purnamasari, A.Md.Keb.
3. apt. Yuanita Eka Lestari, S.Farm
4. apt. Diryati Barin Putri, S.Farm
5. apt. Pipin Purwa Ningrum, S.Farm
6. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm
7. apt. Ajeng Janani, S.Farm
8. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
9. apt. Gadis Arivia, S.Farm
10. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S.Farm
11. apt. Guspa Gayatri Azmi, S.Farm
12. apt. Susanti, S.Farm
13. apt. Dita Ariesa Putri Prajoko, S.Farm
14. apt. Shindy Ariesta Dewiadjie, S.Farm
15. Mahesa Yudistiranti, S. AP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

TIM PENYUSUN..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA vii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan..... 2

1.2.1 Tujuan Umum 2

1.2.2 Tujuan Khusus 2

1.3 Batasan Operasional..... 2

1.4 Sasaran 2

1.5 Pengertian 3

BAB II 4

STANDAR KETENAGAAN..... 4

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia 4

2.2 Distribusi Ketenagaan..... 4

2.3 Pengaturan Jaga..... 5

BAB III 6

STANDAR FASILITAS..... 6

3.1 Denah Ruang 6

3.2 Standar Fasilitas 6

BAB IV..... 11

KEMAMPUAN PELAYANAN..... 11

4.1 Pengertian Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 11

4.2 Kemampuan Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit..... 11

BAB V..... 13

TATA LAKSANA PELAYANAN 13

5.1 Pengorganisasian 13

5.2 Pemilihan, Perencanaan, dan Pengadaan 13

5.2.1 Pemilihan..... 13

5.2.2 Perencanaan Kebutuhan 14

5.2.3 Pengadaan 14

5.2.4 Penerimaan..... 16

5.3 Penyimpanan 17

5.3.1 Penyimpanan 17

5.3.2 Penarikan dan Pemusnahan 22

5.4 Peresepan dan Penyalinan..... 23

5.4.1 Peresepan..... 23

5.4.2 Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat 25

5.4.3 Rekonsiliasi Obat 26

5.5 Penyiapan dan Penyerahan..... 27

5.5.1 Penyiapan 27

5.5.2 Pengkajian dan Pelayanan Resep 29

5.5.3 Telaah Obat 29

5.5.4 Konseling 30

5.6 Pemberian Obat..... 31

5.7 Pemantauan 33

5.7.1	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	33
5.7.2	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	34
5.7.3	Visite.....	37
5.7.4	Evaluasi Penggunaan Obat (EPO).....	42
5.8	Pelayanan Informasi Obat (PIO).....	43
5.9	Pengendalian	44
5.10	Administrasi.....	45
	Pencatatan dan Pelaporan	45
BAB VI.....		46
LOGISTIK.....		46
BAB VII.....		48
KESELAMATAN PASIEN.....		48
7.1	Pengertian	48
7.2	Kategori Medication Error	48
7.3	Alur Pelaporan Insiden ke Tim Keselamatan Pasien (KP) di Rumah Sakit.....	49
7.4	Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)	51
7.5	Analisis Matriks Grading Risiko	52
BAB VIII.....		55
KESELAMATAN KERJA.....		55
8.1	Latar Belakang	55
8.2	Tujuan.....	55
8.3	Pelaksanaan K3 IFRS.....	55
BAB IX.....		58
PENINGKATAN MUTU.....		58
9.1	Prinsip.....	58
9.2	Definisi Indikator.....	58
9.3	Kriteria	58
9.4	Standar	58
BAB X.....		59
PENUTUP		59
DOKUMENTASI.....		60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indikator VVM pada vaksin.....18

Gambar 2. Contoh Pencoretan pada Barcode Vial Vaksin.....23

Gambar 3. Contoh Pencoretan pada Informasi Vaksin23

Gambar 4. Alur Pelaporan Insiden.....50

Gambar 5. Denah Ruang Depo Farmasi60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi pada Rumah Sakit Tipe C Berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016 dan Permenkes No. 3 Tahun 2020.....4

Tabel 2. Pengaturan jaga di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada5

Tabel 3. Fasilitas Utama dalam Kegiatan Pelayanan di Instalasi Farmasi6

Tabel 4. Elemen Penting pada Proses Pengadaan15

Tabel 5. Masa Pemakaian Vaksin Sisa.....18

Tabel 6. Daftar Stabilitas Obat Sesudah Dibuka28

Tabel 7. Waktu Pemberian untuk Obat Oral33

Tabel 8. Waktu Pemberian untuk Obat Injeksi.....33

Tabel 9. Daftar Logistik yang terdapat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada46

Tabel 10. Kategori Kesalahan dalam Pemberian Obat di Instalasi Farmasi49

Tabel 11. Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)51

Tabel 12. Penilaian Dampak Klinis/ Konsekuensi/ Severity52

Tabel 13. Penilaian Probabilitas/ Frekuensi52

Tabel 14. Matriks Grading Risiko53

Tabel 15. Tindakan Sesuai Tingkat dan Bands Risiko54

Tabel 16. Identifikasi Bahaya Potensial55

Tabel 17. Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja56



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 536.4/I-PDM/DIR/V/2025**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perlu menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 407.1/I-PDM/IFRS/V/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi;
16. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;



17. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
- (3) Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- (4) Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- (6) Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- (7) Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
- (8) Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- (10) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
- (11) Apoteker harus terdaftar di Kementerian Kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), memiliki sertifikat kompetensi apoteker dan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).
- (12) Apoteker melakukan supervisi sesuai dengan penugasannya.



- (13) Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang menjalankan praktik kefarmasian, yang dalam melaksanakan praktik tertentu dibawah supervisi apoteker, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga farmasi dan tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga analisis farmasi dan makanan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian;
- b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

BAB III STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar:
 - a. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. pelayanan farmasi klinik.
- (2) Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemilihan;
 - b. Perencanaan kebutuhan;
 - c. Pengadaan;
 - d. Penerimaan;
 - e. Penyimpanan;
 - f. Pendistribusian;
 - g. Pemusnahan dan penarikan;
 - h. Pengendalian;
 - i. Administrasi.
- (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengkajian dan pelayanan resep
 - b. Penelusuran riwayat penggunaan obat;
 - c. Rekonsiliasi obat;
 - d. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
 - e. Konseling;
 - f. Visite;
 - g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
 - h. Monitoring Efek Samping Obat (MESO); dan
 - i. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
 - j. Dispensing sediaan steril.

BAB IV PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 4



- (1) Pemilihan;
 - a. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai pada Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional.
 - b. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur PT. Disa Prima Medika.
 - c. *Review* formularium dilakukan satu tahun sekali berdasarkan informasi tentang keamanan dan efektivitas.
 - d. Obat lama/ baru dikeluarkan dari formularium rumah sakit apabila resiko ketidakamanan obat baru lebih dari efikasinya.
 - e. Instalasi farmasi melakukan pencatatan untuk memantau kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan dan penggunaannya.
 - f. Adanya suatu mekanisme untuk mengatasi ketidaktersediaan obat pada persepsian obat formularium dan non-formularium.
 - g. Rumah Sakit memiliki sumber informasi obat yang tepat, terkini, dan selalu tersedia bagi semua yang terlibat dalam penggunaan obat.
- (2) Perencanaan kebutuhan;
 - a. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode konsumsi dan kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi.
 - b. Perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode ABC dan VEN. Untuk itu dilakukan beberapa langkah evaluasi dalam perencanaan kebutuhan dengan RKO (Rencana Kebutuhan Obat).
- (3) Pengadaan;
 - a. Pengadaan harus berasal dari jalur resmi dengan mempertimbangkan pemilihan pemasok dan metode pengadaan.
 - b. Pengadaan harus berdasarkan kontrak termasuk hak akses untuk meninjau ke tempat penyimpanan dan transportasi sewaktu-waktu.
 - c. Manajemen rantai pengadaan harus menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat dengan adanya garansi keaslian obat, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Instalasi farmasi memproduksi sediaan tertentu yaitu sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/ *repacking* dan produksi non steril sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan internal rumah sakit.
 - e. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan;
 - a. Penerimaan harus menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
- (5) Penyimpanan;
 - a. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus baik, benar, dan aman serta menjamin kualitas meliputi persyaratan stabilitas dan



- keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis. Penyimpanan obat dilengkapi dengan label obat yang berisi nama obat dan dosis.
- b. Pencegahan kehilangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan secara internal dan eksternal.
 - c. Sediaan farmasi yang penampilan dan penamaan yang mirip/ *Look Alike Sound Alike* (LASA) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA pada obat untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Pada obat LASA, label obat dosis rendah berwarna hijau, label dosis sedang berwarna kuning, dan label dosis tinggi berwarna merah. Penyimpanan pada rak LASA harus terempel stiker LASA. Pada obat bukan kategori LASA label obat berwarna putih.
 - d. Penyimpanan obat resiko tinggi merupakan kategori obat *high alert* yang disimpan secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah serta diberi label "*High Alert*". Elektrolit konsentrat merupakan kategori obat *high alert* disimpan dengan lokasi akses terbatas dalam lemari khusus dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker "*High Alert*", "*encerkan*", dan "*LASA*".
 - e. Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih.
 - f. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.
 - g. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (*floor stock, box emergency, kit emergency* dan *trolley emergency*) dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi dengan supervisi Apoteker.
 - h. Obat narkotika dan psikotropika disimpan yang baik, benar, dan aman sesuai peraturan perundang-undangan.
 - i. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika.
 - j. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika.
 - k. Lemari khusus narkotika dan psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.
 - l. Penyimpanan reagensia esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu penyimpanan sesuai yang disarankan oleh produsen, semua reagensia esensial disimpan dan diberi



- label. Penyimpanan reagensia dilengkapi dengan data *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- m. Bahan berbahaya dan beracun (B3) disimpan dalam lemari khusus dimana tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai dengan klasifikasi. Bahan kimia yang terbuka diberi label yang secara jelas.
 - n. Penyimpanan gas medis rumah sakit berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Instalasi Farmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - o. Obat oral, injeksi, serta produk nutrisi enteral maupun parenteral disimpan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen.
 - p. Semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit harus dicatat dalam formulir riwayat penggunaan obat dan berita acara serah terima obat yang dibawa dari rumah kemudian obat disimpan pada keranjang pasien obat dari rumah di depo farmasi sesuai dengan stabilitas penyimpanan.
 - q. Obat yang diberi oleh pemerintah (obat hibah) di Rumah Sakit Prima Husada adalah obat TBC, antivirus covid-19, vaksin covid-19, obat KB, vaksin imunisasi dasar yang disimpan dengan baik, benar, dan aman sesuai dengan stabilitasnya.
 - r. Tidak terdapat obat sitotastik/ kemoterapi, obat dan bahan radioaktif, obat yang digunakan khusus untuk penelitian, dan bahan baku obat di RS Prima Husada.
 - s. Pelabelan obat harus dilakukan sebelum diserahkan kepada pasien meliputi identitas pasien, nama obat, dosis atau konsentrasi, cara pemakaian, waktu pemberian, tanggal disiapkan, dan tanggal kedaluwarsa.
- (6) Pendistribusian;
- a. Penyiapan dan penyerahan yang digunakan oleh instalasi farmasi dalam mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain: Resep Perorangan, *Floor Stock*, dan *Unit Dose Dispensing* (UDD) untuk rawat inap dan Resep Perorangan untuk rawat jalan.
 - b. Penyaluran obat rawat inap tepat waktu dan tercatat di Daftar Pemberian Obat (DPO) dalam satu daftar rekam medis pasien yang berisi identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter, dan keterangan bila perlu, *tapering off*, titrasi, dan rentang dosis.
 - c. Proses serah terima obat di rawat inap dari apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi dilakukan oleh perawat atau bidan yang kompeten.
 - d. Penyerahan obat harus dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan instruksi pengobatan meliputi benar identitas pasien, benar nama obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu pemberian.
 - e. Pada proses pemberian obat di rawat inap dilakukan batasan terhadap bidan/ perawat. Obat oral di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1. Obat injeksi di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang terlatih. Vaksin boleh diberikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang diberi mandat oleh dokter yang bersangkutan dan sudah terlatih. Elektrolit konsentrat dan



injeksi sedasi ringan hanya diberikan oleh perawat minimal PK 2 yang terlatih atau perawat penanggungjawab shift. Pemberian obat dalam sendi dan intrathecal hanya dilakukan oleh DPJP yang terlatih dan memiliki sertifikasi.

(7) Pemusnahan dan Penarikan;

- a. Petugas farmasi melakukan pemusnahan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bila: produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kedaluwarsa; tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, dan/atau dicabut izin edarnya.
- b. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ ketentuan peraturan perundang - undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*). Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.

(8) Pengendalian;

- a. Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengendalian penggunaan dilakukan oleh Instalasi Farmasi bersama dengan Komite Farmasi dan Terapi.
- b. Petugas Instalasi Farmasi wajib melakukan *stock opname* di tanggal akhir bulan selama 1 bulan sekali.
- c. Perawat penanggungjawab di Instalasi yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ikut melakukan *stock opname* di tanggal akhir bulan bersama dengan petugas Instalasi Farmasi.
- d. Penggantian *box/trolley/kit emergency* dilakukan dalam waktu kurang dari 5 menit setelah ada laporan pembukaan *box/trolley/kit emergency* oleh unit terkait.

(9) Administrasi.

- a. Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semester atau per tahun).
- b. Apoteker penanggungjawab instalasi farmasi melakukan pelaporan penerimaan dan pengeluaran sediaan farmasi narkotika dan psikotropika melalui sipnap.

BAB V

PELAYANAN FARMASI KLINIK

Pasal 5

(1) Pengkajian dan Pelayanan Resep;

- a. Peresepan/ permintaan obat dan instruksi pengobatan harus ditulis secara benar, lengkap, dan terbaca sesuai aturan



- penulisan resep.
- b. Dokter yang boleh menulis resep di RS Prima Husada adalah semua dokter yang telah memiliki SIP di RS Prima Husada yang mendapatkan Surat Penugasan Klinis dari Direktur Rumah Sakit serta memuat Rincian Kewenangan Klinis yang boleh dilakukan.
 - c. Resep resmi harus ditulis oleh dokter peminta, bila pesanan obat per telepon, resep dituliskan oleh dokter jaga IGD sesuai dengan *advice* per telepon oleh dokter spesialis baik sesuai nama generik ataupun nama paten.
 - d. Semua dokter yang telah memiliki SIP di RS Prima Husada yang menulis resep/ permintaan obat/ memberi instruksi pengobatan umum.
 - e. Rumah Sakit menetapkan dokter beserta daftar dokter yang berhak menulis resep/ permintaan obat/ memberi instruksi pengobatan khusus (psikotropika dan narkotika).
 - f. Syarat elemen resep lengkap yang meliputi data identitas pasien secara akurat (dengan stiker), elemen pokok di semua resep atau permintaan obat atau instruksi pengobatan, penggunaan nama dagang atau generik, penggunaan indikasi seperti pada PRN (*pro re nata* atau “jika perlu”) atau instruksi pengobatan lain, jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak, lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya, kecepatan pemberian (jika berupa infus), instruksi khusus, sebagai contoh: *titrasi, tapering off, standing order, automatic stop order*, rentang dosis.
 - g. Ditetapkan proses untuk menangani atau mengelola hal-hal di bawah ini:
 - Resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca.
 - Resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (*Look Alike Sound Alike*).
 - Jenis resep khusus, seperti emergensi, cito, berhenti otomatis (*automatic stop order*), *tapering*, dan lainnya.
 - Instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi.
- (2) Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat;
- a. Obat yang digunakan pasien yang berasal dari luar rumah sakit harus dengan persetujuan DPJP yang dikelola oleh Instalasi Farmasi.
 - b. Penggunaan obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit didokumentasikan di formulir riwayat penggunaan obat serta dibuat berita acara penerimaan obat. Obat yang dibawa pasien dari rumah baik diteruskan atau untuk dihentikan, harus dilakukan pencatatan oleh petugas farmasi pada kartu stok, kemudian sisa obat harus dikembalikan kepada pasien. Obat pasien yang dibawa dari rumah disimpan pada keranjang pasien obat dari rumah di Depo Farmasi.
 - c. Penggunaan obat oleh pasien secara mandiri diperbolehkan oleh Rumah Sakit atas dasar kenyamanan pasien pada sediaan sirup, inhalasi, insulin, rectal, dan intravagina. Petugas



- Instalasi Farmasi melakukan edukasi yang di buktikan mengisi hasil edukasi di dalam rekam medis pada formulir pemberian edukasi dan meminta persetujuan pasien dengan mengisi surat pernyataan pengobatan sendiri. Kemudian dilakukan pemantauan penggunaan dengan cara mengisi form monitoring pengobatan sendiri untuk menghindari obat yang tidak tepat.
- d. Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat harus dicatat dalam Form Catatan Riwayat Penggunaan Obat oleh Apoteker.
- (3) Rekonsiliasi Obat;
- a. Penulisan rekonsiliasi obat pada saat pasien masuk, pindah unit pelayanan, dan sebelum pulang dari rumah sakit dilakukan oleh apoteker.
- (4) Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- a. Instalasi Farmasi menyediakan dan memberikan informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif kepada dokter, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien.
- (5) Konseling;
- a. Apoteker melakukan konseling dengan kriteria pasien yang mendapatkan terapi polifarmasi dan penyakit kronis di rawat jalan dan/ataupun rawat inap secara random sampling setiap minggunya.
- (6) Visite pasien;
- a. Apoteker melakukan visite pada setiap pasien di rawat inap baik secara mandiri ataupun bersama tim tenaga kesehatan lain.
- (7) Pemantauan Terapi Obat (PTO);
- a. Apoteker rawat inap melakukan pemantauan terapi obat untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien dan dicatat dalam status pasien.
- b. Pemantauan Terapi Obat harus dicatat dalam Form Pemantauan Terapi Obat oleh Apoteker.
- (8) Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
- a. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) obat baru, dilakukan selama 3 bulan pertama serta dipantau secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
- b. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan Pemantauan Reaksi Obat Tidak Dikehendaki (ROTD) dilaksanakan secara kolaboratif antara dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ditulis di dalam dokumen rekam medik pasien dan dilaporkan selambat - lambatnya 1 x 24 jam dalam bentuk laporan MESO dan dicatat dalam status pasien.
- (9) Dispensing Sediaan Steril;
- a. Pencampuran obat intravena dilakukan oleh Apoteker dan atau Tenaga Vokasi Farmasi yang terlatih dan memahami prinsip penyiapan obat di ruang pencampuran obat dan teknik aseptis.
- b. Pencampuran obat injeksi dilakukan di ruang aseptis dispensing dengan menggunakan LAF sesuai standar prosedur operasional.
- c. Petugas farmasi harus melakukan pembersihan alat racik setiap sebelum dan sesudah melakukan kegiatan peracikan sediaan farmasi.



BAB VI

PELAYANAN KEFARMASIAN RUMAH SAKIT

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu.
- (3) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggungjawab.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dapat dibentuk satelit farmasi sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (5) Review kajian pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.

BAB VII

PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 7

- (1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan *medication safety* yang bertujuan mengarahkan penggunaan obat yang aman dan meminimalisasi kemungkinan terjadi kesalahan penggunaan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instalasi Farmasi ikut serta dalam proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien bersama Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- (3) Rumah Sakit menerapkan sistem pelaporan kesalahan penggunaan obat yang menjamin laporan akurat dan tepat waktu.
- (4) Setiap kesalahan penggunaan obat harus membuat laporan insiden keselamatan pasien.
- (5) Rumah Sakit memiliki upaya untuk mendeteksi, mencegah dan mengurangi kesalahan penggunaan obat

BAB VIII

RETUR OBAT

Pasal 8

Obat pulang rawat inap atau rawat jalan yang ditinggal oleh pasien disimpan di Instalasi Farmasi, maksimal 2x24 jam, bila melebihi ketentuan maka obat diretur kecuali kondisi tertentu.

Pasal 9

Pengembalian (retur obat) pasien segera dikembalikan oleh perawat yang bersangkutan kepada instalasi farmasi.

Pasal 10

Obat suntik yang tertinggal di rumah sakit baik pulang hidup atau meninggal harus dimusnahkan.



BAB IX
PENGUNAAN OBAT

Pasal 11

Pasien BPJS menggunakan obat generik sesuai Formularium Nasional dan *e-catalog*.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Setiap Tenaga Kefarmasian yang menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit wajib mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 407.1/I-PDM/IFRS/V/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR: 536.4/I-PDM/DIR/V/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI

PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Untuk itu kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus agar perubahan paradigma tersebut dapat diimplementasikan. Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. Dengan demikian, para Apoteker Indonesia dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Perkembangan di atas dapat menjadi peluang sekaligus merupakan tantangan bagi Apoteker untuk maju meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan Pelayanan Kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik.

Obat merupakan komponen penting dalam pengobatan simptomatik, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitative terhadap penyakit dan berbagai kondisi. Rumah sakit menerapkan prinsip rancang proses yang efektif, implementasi dan peningkatan mutu terhadap seleksi, pengadaan, penyimpanan, peresepan atau permintaan obat atau instruksi pengobatan, penyalinan (*transcribe*), pendistribusian, penyiapan (*dispensing*), pemberian, pendokumentasian, dan pemantauan terapi obat. Praktik penggunaan obat yang tidak aman (*unsafe medication practices*) dan kesalahan penggunaan obat (*medication errors*) adalah penyebab utama cedera dan bahaya yang dapat dihindari dalam sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Oleh karena itu, rumah sakit diminta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, membuat sistem pelayanan kefarmasian, dan penggunaan obat yang lebih aman yang senantiasa berupaya menurunkan kesalahan pemberian obat.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau.

Selanjutnya dinyatakan bahwa pelayanan Sediaan Farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian yang selanjutnya diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktik kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Tersedianya pedoman pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik di Rumah Sakit.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia.
2. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
4. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
5. Melindungi pasien, masyarakat, dan karyawan dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).
6. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).
7. Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.

1.3 Batasan Operasional

Batasan operasional instalasi farmasi mencakup proses:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi kegiatan merancang proses yang efektif, penerapan, dan perbaikan terhadap pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi,
2. Farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dan dispensing sediaan steril.

1.4 Sasaran

Pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi. Tenaga Vokasi Farmasi yang melakukan pelayanan kefarmasian harus di bawah supervisi Apoteker.

Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi harus memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Pengertian

- a. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- b. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.
- c. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- d. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- f. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
- g. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme.
- h. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- i. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- j. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
- k. Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang menjalankan praktik kefarmasian, yang dalam melaksanakan praktik tertentu dibawah supervisi apoteker, yang terdiri atas tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga farmasi dan tenaga vokasi farmasi lulusan diploma tiga analisis farmasi dan makanan.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, dilaksanakan oleh tenaga farmasi profesional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik dari aspek hukum, strata pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan farmasi dilakukan oleh profesi apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi.

Tenaga profesi Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi yang bertugas di RS Prima Husada memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada dipimpin oleh Apoteker.
2. Pelayanan kefarmasian diselenggarakan dan dikelola oleh Apoteker yang mempunyai pengalaman di bagian farmasi rumah sakit.
3. Apoteker telah terdaftar di Kementerian Kesehatan dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker dan memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA).
4. Pada pelaksanaannya apoteker dibantu oleh Tenaga Vokasi Farmasi dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Vokasi Farmasi serta mempunyai Surat Izin Praktek (SIP).
5. Kepala instalasi farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi.
6. Setiap saat harus ada apoteker di tempat pelayanan untuk melangsungkan dan mengawasi pelayanan farmasi dan harus ada pendelegasian wewenang yang bertanggung jawab bila apoteker berhalangan.
7. Adanya uraian tugas bagi karyawan dan pimpinan farmasi.
8. Adanya karyawan farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
9. Ada apoteker yang memiliki kualifikasi pendidik/pengajar untuk mengawasi jalannya pelatihan kefarmasian bagi mahasiswa fakultas farmasi dan atau tenaga farmasi lain.
10. Penilaian terhadap karyawan harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan.

2.2 Distribusi Ketenagaan

Standar apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi pada rumah sakit tipe C terdiri dari :

Tabel 1. Standar Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi pada Rumah Sakit Tipe C Berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016 dan Permenkes No. 3 Tahun 2020

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM		Keterangan
		Standar	Kondisi Saat Ini	
1	Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit	1 orang	1 orang	Sesuai
2	Apoteker Rawat Jalan	6 orang	5 orang	Tidak sesuai

3	Tenaga Vokasi Farmasi	27 orang	25 orang	Tidak sesuai
4	Apoteker Rawat Inap	5 orang	5 orang	Sesuai
5	Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi	1 orang	1 orang	Sesuai
6	Tenaga Vokasi Farmasi Penerimaan, Distribusi, dan Produksi	2 orang	1 orang	Tidak sesuai

2.3 Pengaturan Jaga

Pengaturan jaga di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Pengaturan jaga di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

Nama Jabatan	Waktu Kerja	Definisi Waktu Kerja
Kepala Instalasi Farmasi	1 shift	08.00-16.00
Apoteker Rawat Jalan	2 shift	06.30-14.00 14.00-21.00
Tenaga Vokasi Farmasi	3 shift	06.30-14.00 14.00-21.00 21.00-07.00
Apoteker Rawat Inap	2 shift	06.30-14.00 14.00-21.00
Apoteker Koordinator Penerimaan, Distribusi, dan Produksi	1 shift	08.00-16.00
Tenaga Vokasi Farmasi Penerimaan, Distribusi, dan Produksi	1 shift	08.00-16.00

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang

Denah ruang Instalasi Farmasi dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5 (Lampiran).

3.2 Standar Fasilitas

1. Bangunan

Fasilitas bangunan, ruangan, dan peralatan di Instalasi Farmasi memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi menyatu dengan sistem pelayanan rumah sakit.
- b. Luas yang cukup untuk penyelenggaraan asuhan kefarmasian di rumah sakit.
- c. Dipisahkan antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung pada pasien, dan *dispensing*.
- d. Memenuhi persyaratan ruang tentang suhu, pencahayaan, kelembaban, tekanan dan keamanan baik dari pencuri maupun binatang pengerat.
- e. Ruang penyimpanan memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, sinar/cahaya, kelembaban, ventilasi, dan sistem pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas.
- f. Ruang pelayanan cukup untuk seluruh kegiatan pelayanan farmasi rumah sakit dan terpisah antara ruang pelayanan pasien rawat jalan, pelayanan pasien rawat inap dan pelayanan kebutuhan ruangan.

2. Sarana

Fasilitas ruang harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas agar dapat menunjang fungsi dan proses pelayanan kefarmasian, menjamin lingkungan kerja yang aman untuk petugas, dan memudahkan sistem komunikasi rumah sakit. Fasilitas utama dalam kegiatan pelayanan di Instalasi Farmasi, terdiri dari:

Tabel 3. Fasilitas Utama dalam Kegiatan Pelayanan di Instalasi Farmasi

No	Nama Ruangan	Persyaratan Ruangan	Keterangan
1.	Ruang Administrasi dan Kantor		
	a. Ruangan kepala instalasi	Umum	Ruangn tergabung
	b. Ruangan karyawan	Umum	
	c. Ruangan kerja dan administrasi tata usaha	Umum	
	d. Ruangan pertemuan	Umum	Ruangn tersentral di Rumah Sakit
2.	Ruangan Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai		
	a. Ruangan Penyimpanan Kondisi Umum		
	- Ruangan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan	▪ Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan	Ruangan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan,

	bahan medis habis pakai	- Total pertukaran udara minimal 4x/jam dengan tekanan udara positif - Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25°C	dan bahan medis habis pakai dan ruangan penyimpanan obat produksi dapat digabung
	- Ruangan penyimpanan obat produksi		
	- Ruangan penyimpanan alat kesehatan		
b. Ruangan Penyimpanan Kondisi Khusus			
	- Ruangan penyimpanan obat khusus (obat yang termolabil, narkotika dan psikotropika, serta obat/bahan berbahaya)	- Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan - Setiap ruangan disediakan minimal dua kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan - Stop kontak khusus alat simpan obat khusus harus disediakan tersendiri yang kompatibel dengan alat yang akan dipakai - Total pertukaran udara minimal 4x/jam dengan tekanan udara positif - Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25°C	Ruangan penyimpanan obat khusus adalah opsional
3.	Ruangan Produksi Sediaan Farmasi		
	a. Ruangan Produksi Sediaan Farmasi Non Steril		
	- Ruangan produksi non steril/ peracikan obat	- Luas ruangan minimal dua kali daerah kerja termasuk peralatan, dengan jarak setiap peralatan minimal 2,5 m - Total pertukaran udara minimal 4x/jam dengan tekanan udara positif - Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25°C	Ruangan produksi non steril/ peracikan obat tidak dipersyaratkan ada
	b. Ruangan <i>Aseptic Dispensing</i> (Pencampuran Obat Suntik)		
	Ruangan bersih (<i>clean room</i>)	- Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan - Total pertukaran udara 20-40x/jam dengan tekanan udara positif - Kelas ruangan 10.000 - Aliran udara laminar - Hindari ruangan bersudut	Ruangan dispensing sediaan farmasi pencampuran obat suntik tidak dipersyaratkan ada

		▪ Setiap ruangan disediakan minimal dua kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan ▪ Stop kontak khusus LAF disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai ▪ Terdapat alat BSC/LAF dengan kelas ruangan 100 dengan pertukaran udara minimal 120x/jam dengan tekanan udara positif ▪ Temperatur ruangan dipelihara pada 15-25°C ▪ Kelembaban relatif 50-60%	
	▪ Ruang antara	▪ Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan ▪ Total pertukaran udara minimal 20x/jam dengan tekanan udara positif tetapi lebih rendah dari <i>clean room</i> ▪ Kelas ruangan 100.000 ▪ Hindari ruangan bersudut	
	▪ Ruang penyimpanan obat produksi	▪ Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan ▪ Total pertukaran udara minimal 20x/jam dengan tekanan udara positif tetapi lebih rendah dari ruangan antara ▪ Kelas ruangan 100.000 ▪ Hindari ruangan bersudut ▪ Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25°C	
	▪ Ruang ganti pakaian	▪ Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan ▪ Total pertukaran udara minimal 12x/jam dengan tekanan udara netral ▪ Hindari ruangan bersudut	
4.	Ruang Penunjang Lain		

	a. Loker Depo Farmasi (Loker penerimaan resep, loker pembayaran dan loker pengambilan obat)	Umum	
	b. Ruang arsip dokumen dan perpustakaan	Umum	
	c. Ruang tunggu	- Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang - Total pertukaran udara minimal 6x/jam - Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi tangan	
5.	Ruang Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (Depo)		
	a. Ruang produksi obat non steril/ racik obat	- Luas ruang menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan - Total pertukaran udara minimal 4x/jam dengan tekanan udara positif - Temperatur ruang dipelihara pada suhu 15-25°C	Ketersediaan ruang ini adalah opsional
	b. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai	- Luas ruang menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan - Total pertukaran udara minimal 4x/jam dengan tekanan udara positif - Temperatur ruang dipelihara pada suhu 15-25°C	Ketersediaan ruang ini adalah opsional
	c. Ruang apoteker	Umum	Ketersediaan ruang ini adalah opsional
	d. Ruang pelayanan informasi obat	Umum	
	e. Ruang konseling obat	Umum	
	f. Loker satelit farmasi	Umum	Ketersediaan ruang ini adalah opsional
	g. Ruang	Umum	Ketersediaan

	administrasi (penerimaan dan distribusi obat)		ruangan ini adalah opsional
--	--	--	-----------------------------

3. Peralatan

Fasilitas peralatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan terutama untuk perlengkapan *dispensing* sediaan steril maupun nonsteril. Fasilitas peralatan harus dijamin sensitif pada pengukuran dan memenuhi persyaratan, penaraan dan kalibrasi untuk peralatan tertentu setiap tahun. Data peralatan instalasi farmasi dapat dilihat pada Bab VI Logistik.

BAB IV

KEMAMPUAN PELAYANAN

4.1 Pengertian Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk :

1. Menjamin mutu, manfaat, keamanan, serta khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan.
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
3. Melindungi pasien, masyarakat, dan staf dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).
4. Menjamin sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang lebih aman (*medication safety*).
5. Menurunkan angka kesalahan penggunaan obat.

4.2 Kemampuan Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit

A. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

1. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.
2. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara optimal untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien.
3. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu.
4. Penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi yang berlaku untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima
5. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian.
6. Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ke unit pelayanan di rumah sakit atau pasien.
7. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu.
8. Pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus bersama dengan Komite Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit. Pelaksanaan monitoring kepatuhan terhadap formularium baik dari persediaan maupun penggunaannya.
9. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

B. Pelayanan farmasi klinik

1. Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

-
2. Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat/ sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik/ pencatatan penggunaan obat pasien.
 3. Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien dan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*medication error*) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat
 4. Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien dan pihak lain di luar Rumah Sakit
 5. Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari Apoteker (konselor) kepada pasien dan/atau keluarganya.
 6. Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya.
 7. Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien.
 8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap Obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi. Efek Samping Obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi.
 9. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif.
 10. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di Instalasi Farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat.

BAB V

TATA LAKSANA PELAYANAN

5.1 Pengorganisasian

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat yang meliputi:

1. Perencanaan sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat.
2. Pemilihan.
3. Perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.
4. Penyimpanan.
5. Pendistribusian.
6. Peresepan/ permintaan obat/ instruksi pengobatan.
7. Penyajian (dispensing).
8. Pemberian obat.
9. Pemantauan terapi obat.
10. Monitor seluruh angka kesalahan penggunaan obat (*medication error*) meliputi kejadian tidak diharapkan, kejadian sentinel, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera serta upaya mencegah dan menurunkannya.
11. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
12. Pertimbangan melakukan kegiatan baru berbasis bukti (*evidence based*).

Untuk memastikan efektivitas sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, maka rumah sakit melakukan kajian sekurang-kurangnya sekali setahun. Kajian tahunan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi dan pengalaman yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, termasuk jumlah laporan insiden kesalahan obat serta upaya untuk menurunkannya. Pelaksanaan kajian melibatkan Komite Farmasi dan Terapi, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, serta unit kerja terkait. Kajian bertujuan agar rumah sakit memahami kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan. Kajian meliputi proses-proses poin 1 sampai 12.

Pelayanan kefarmasian dipimpin oleh apoteker yang memiliki izin dan kompeten dalam melakukan supervisi semua aktivitas pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit. Apoteker berperan serta dalam terlaksananya pelaporan kesalahan penggunaan obat serta tindak lanjut terhadap kesalahan penggunaan obat untuk memperbaiki sistem manajemen penggunaan obat. Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat bukan hanya tanggung jawab apoteker, tetapi juga staf lainnya yang terlibat, misalnya dokter, perawat, Tenaga Vokasi Farmasi, staf non klinis. Struktur organisasi dan tata hubungan kerja operasional pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat di rumah sakit mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Rumah sakit harus menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan staf yang terlibat dalam pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, misalnya informasi tentang dosis, interaksi obat, efek samping obat, stabilitas dan kompatibilitas dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.

5.2 Pemilihan, Perencanaan, dan Pengadaan

5.2.1 Pemilihan

Rumah sakit menetapkan formularium obat mengacu pada peraturan perundang-undangan. Formularium ini didasarkan atas misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan yang diberikan. Penyusunan formularium merupakan suatu proses kolaboratif mempertimbangkan kebutuhan, keselamatan pasien dan aspek biaya.

Formularium harus dijadikan acuan dan dipatuhi dalam persepan dan pengadaan obat. Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang disetujui oleh Direktur Rumah Sakit dan ditetapkan oleh Direktur PT. Disa Prima Medika. Komite Farmasi dan Terapi melakukan evaluasi terhadap formularium rumah sakit sekurang-kurangnya setahun sekali dengan mempertimbangkan efektivitas, keamanan dan biaya. Kriteria pemilihan, penambahan, dan penghapusan obat selengkapnya dijelaskan pada Pedoman Kerja Komite Farmasi dan Terapi. Obat baru yang ditambahkan dalam formularium dilakukan pemantauan penggunaan obat bila terjadi reaksi obat yang tidak diharapkan, efek samping, serta *medication error*. Kepatuhan penggunaan obat terhadap formularium rumah sakit baik dari persediaan maupun penggunaannya didokumentasikan pada formulir monitoring dan evaluasi dan dibahas dalam rapat Komite Farmasi dan Terapi.

5.2.2 Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan dengan metode konsumsi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Perencanaan kebutuhan dilakukan oleh apoteker penanggungjawab dibantu oleh apoteker dan/atau Tenaga Vokasi Farmasi yang bertugas di gudang instalasi farmasi.

Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan :

1. Anggaran yang tersedia,
2. Penetapan prioritas,
3. Sisa persediaan,
4. Data pemakaian periode yang lalu,
5. Buffer dan waktu tunggu pemesanan,
6. Rencana pengembangan.

Dalam perencanaan kebutuhan obat menggunakan metode kombinasi ABC dan VEN sebagai salah satu langkah efisiensi. Petunjuk teknis mengenai metode kombinasi ABC dan VEN diatur lebih lanjut di Panduan *Supply Chain Management*.

5.2.3 Pengadaan

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang melibatkan apoteker untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manajemen rantai distribusi obat adalah faktor yang sangat penting dalam menjamin pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai rumah sakit yang aman dan berkualitas. Rantai distribusi obat ini meliputi tahapan bagaimana sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dikirim dari pabrik ke distributor dan akhirnya sampai ke rumah sakit.

Beberapa elemen penting pada proses pengadaan meliputi :

1. Pengadaan harus berasal dari jalur resmi dengan mempertimbangkan pemilihan pemasok dan pemilihan metode pengadaan.
2. Pengadaan harus berdasarkan kontrak termasuk hak akses untuk meninjau ke tempat penyimpanan dan transportasi sewaktu-waktu.
3. Pengadaan harus menjamin garansi keaslian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan di lengkapi :

Tabel 4. Elemen Penting pada Proses Pengadaan

Barang	Lampiran
1. Sediaan Farmasi	- Nomor Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
2. Alat Kesehatan	- Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan - <i>Certificate of Origin</i>
3. Bahan Medis Habis Pakai	- Nomor Izin Edar dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	- <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) atau Lembar Data Pengaman (LDP)

4. Pengadaan dilakukan kepada distributor resmi yang memiliki ikatan kerjasama untuk menjamin mutu, manfaat, khasiat, keaslian, serta ketersediaan produk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pengadaan harus memenuhi persyaratan masa kedaluwarsa minimal 2 tahun dari tanggal dilakukan pengadaan kecuali untuk sediaan farmasi tertentu (Vaksin).

Pengadaan RS Prima Husada terdiri dari:

1. Pembelian
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah :
 - a. Pembelian di distributor resmi yang memiliki kontrak dengan RS Prima Husada.
 - b. Pengadaan dapat melakukan pembelian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada apotek atau rumah sakit lain yang memiliki kontrak dengan RS Prima Husada untuk menjamin keaslian obat.
 - c. Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
 - d. Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.
2. Produksi sediaan farmasi
Instalasi farmasi memproduksi sediaan tertentu yaitu:
 - a. Sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/ *repacking*, contoh: pengemasan salep burnazin, povidon iodine 20 ml, asam asetat 2%.
 - b. Produksi non steril, contoh: pembuatan *chlorine*.
3. Sumbangan/ *dropping*/ hibah
Contoh: obat TBC, antivirus covid-19, vaksin covid-19, obat KB, vaksin imunisasi dasar.

Rangkaian distribusi ini merupakan komponen sangat penting untuk penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan datang tepat waktu, mencegah obat serta teknologi medik yang tercemar, palsu, sampai dipergunakan kepada pasien di rumah sakit. Hal ini merupakan masalah global yang sudah dikenal dan untuk mengatasinya harus diketahui tentang reputasi, kredibilitas, kegiatan operasional setiap komponen, dari rantai distribusi. Jika sebuah

rumah sakit tidak mengetahui informasi tentang integritas setiap pemasok (*supplier*) di rantai distribusi maka rumah sakit dapat minta informasi untuk mengetahui bagaimana sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dibeli dan dikelola oleh pemerintah atau badan nonpemerintah. Khusus untuk pembelian alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan obat yang berisiko termasuk vaksin maka rumah sakit agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
2. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP).
3. NPWP.
4. Izin Pedagang Besar Farmasi - Penyalur Alat Kesehatan (PBF - PAK).
5. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan *principal* serta rumah sakit.
6. Nama dan Surat izin Kerja Apoteker untuk apoteker penanggung jawab PBF.
7. Alamat dan denah kantor PBF.
8. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari *principal*).

Hal-hal yang mengakibatkan penundaan pengadaan maka petugas farmasi wajib :

1. Selalu kontrol stok minimal sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. Pemberitahuan kepada staf medis tentang kekosongan obat serta saran substitusinya.
3. Membuat kerjasama yang baik dan jelas kepada distributor agar meminimalisir terjadinya kekosongan obat.
4. Membuat kerjasama yang baik dan jelas kepada distributor alat kesehatan agar alat yang dibutuhkan selalu tersedia dan mudah serta cepat didapatkan.

Penyebabnya jumlah stok telah habis antara lain :

1. Kelalaian petugas farmasi untuk melakukan kontrol sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah mencapai stok minimal.
2. Keterlambatan petugas farmasi dalam melakukan permintaan ke unit pengadaan.
3. Keterlambatan unit pengadaan dalam melakukan pengadaan.
4. Kondisi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kosong pabrik/ distributor.
5. Keterlambatan dan atau kesalahan pengiriman dari distributor.

Cara pengadaan apabila obat tidak tersedia diatur lebih lanjut di Panduan *Supply Chain Management*.

5.2.4 Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan oleh apoteker koordinator penerimaan, distribusi, dan produksi yang dibantu Tenaga Vokasi Farmasi yang kompeten. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diterima harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit dan harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Petugas yang dilibatkan dalam penerimaan harus terlatih baik dalam tanggung jawab dan tugas, serta harus mengerti sifat penting dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus ditempatkan dalam tempat persediaan, segera setelah diterima, harus segera disimpan dalam tempat penyimpanan sesuai standar.

Pedoman dalam penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai :

1. Mencocokkan faktur dari distributor dengan surat pesanan.
2. Memeriksa kesesuaian dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan.
3. Pengiriman produk dilengkapi dengan persyaratan pengadaan.
4. Khusus vaksin harus diperiksa cool box dan catatan pemantauan suhu dalam perjalanan.

5.3 Penyimpanan

5.3.1 Penyimpanan

Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian meliputi persyaratan stabilitas suhu dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, mudah tidaknya terbakar, dan penggolongan bentuk sediaan dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan pengawasan oleh apoteker melalui supervisi apoteker.

Untuk mendapatkan kemudahan dalam penyimpanan, penyusunan, pencarian dan pengawasan, diperlukan pengaturan tata ruang gudang dengan baik. Gudang menggunakan sistem dua lantai untuk meningkatkan kapasitas tanpa menambah luas lahan, tidak menggunakan sekat-sekat karena akan membatasi pengaturan ruangan. Jika digunakan sekat, perhatikan posisi dinding dan pintu untuk mempermudah gerakan. Berdasarkan arah arus penerimaan dan pengeluaran, ruang gudang dapat ditata berdasarkan sistem arus U. Gudang farmasi harus memiliki sirkulasi udara yang cukup. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sekaligus bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi kerja. Penempatan rak yang tepat dan penggunaan palet akan dapat meningkatkan sirkulasi udara dari bawah dan perlindungan terhadap banjir, peningkatan efisiensi penanganan stok, dapat menampung sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lebih banyak, serta lebih murah dari pada rak.

Kerusakan obat-obatan, bahan-bahan, reagensia, alkes dan lainnya yang disebabkan penyimpangan suhu ruangan, lemari pendingin, lemari pembeku tempat penyimpanan maka harus segera dilaporkan ke Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS) dalam waktu 1 x 24 jam.

Metode penyimpanan dilakukan berdasarkan bentuk sediaan, jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out (FEFO)* dan *First In First Out (FIFO)* disertai sistem informasi manajemen.

Penyimpanan dikategorikan sebagai berikut :

1. Sediaan farmasi kategori LASA dan bukan LASA

Penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip/ *Look Alike Sound Alike (LASA)* tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus yakni stiker LASA untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Penyimpanan obat

dilengkapi dengan label obat yang berisi nama obat dan dosis. Pada obat LASA, label obat dosis rendah berwarna hijau, label dosis sedang berwarna kuning, dan label dosis tinggi berwarna merah. Penyimpanan pada rak LASA harus tertempel stiker LASA. Pada obat bukan kategori LASA, label obat berwarna putih. Obat dan zat kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama obat, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kedaluwarsa dan peringatan khusus. Sediaan farmasi harus disimpan di tempat sejuk, kering, terhindar dari sinar matahari sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen.

Vaksin memerlukan “Cold Chain” khusus dan harus dilindungi dari kemungkinan terputusnya arus listrik. Semua vaksin disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *vaccine refrigerator*. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemakaian vaksin secara berurutan adalah paparan vaksin terhadap panas, masa kedaluwarsa vaksin, waktu pendistribusian/ penerimaan serta ketentuan pemakaian sisa vaksin.

- a. Keterpaparan Vaksin terhadap Panas
Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak (yang dinyatakan dengan perubahan kondisi Vaccine Vial Monitor (VVM) A ke kondisi B) harus digunakan terlebih dahulu meskipun masa kedaluwarsanya masih lebih panjang. Vaksin dengan kondisi VVM C dan D tidak boleh digunakan.

Gambar 1. Indikator VVM pada vaksin



- b. Masa Kedaluwarsa Vaksin
Apabila kondisi VVM vaksin sama, maka digunakan vaksin yang lebih pendek masa kedaluwarsanya (First Expire First Out/ FEFO).
- c. Waktu Penerimaan vaksin (First In First Out/ FIFO)
Vaksin yang terlebih dahulu diterima sebaiknya dikeluarkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa vaksin yang diterima lebih awal mempunyai jangka waktu pemakaian yang lebih pendek.
- d. Pemakaian Vaksin Sisa
Vaksin sisa pada Rumah Sakit bisa digunakan pada pelayanan hari berikutnya. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah :
 - a) Disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C
 - b) VVM dalam kondisi A atau B
 - c) Belum kadaluwarsa
 - d) Tidak terendam air selama penyimpanan
 - e) Belum melampaui masa pemakaian.

Tabel 5. Masa Pemakaian Vaksin Sisa

Jenis Vaksin	Masa Pemakaian	Keterangan
Polio	2 Minggu	Cantumkan tanggal pertama kali vaksin digunakan
IPV	4 Minggu	
DT	4 Minggu	

Td	4 Minggu	Cantumkan waktu vaksin dilarutkan
DPT-HB-Hib	4 Minggu	
BCG	3 Jam	
Campak	6 Jam	

2. Narkotika dan psikotropika
- Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika. Lemari khusus narkotika dan psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, kunci lemari khusus dikuasai oleh Apoteker penanggung jawab/ Apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Kunci lemari narkotika dan psikotropika tidak boleh dibiarkan tergantung pada lemari. Setiap pergantian shift harus dilakukan pemeriksaan stok dan serah terima yang didokumentasikan. Keamanan obat narkotika dan psikotropika dapat di monitoring dari hasil pelaporan narkotika dan psikotropika oleh apoteker penanggungjawab melalui SIPNAP.
3. Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
- Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai disimpan berdasarkan jenis sediaan dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out (FEFO)* dan *First In First Out (FIFO)*.
- Pada alat kesehatan yang sudah terpakai yang disterilisasi di CSSD, maka masa kedaluwarsa ditentukan dengan cara melaksanakan kultur alat yang sudah disterilisasi setiap bulan hingga 6 bulan. Apabila di bulan keenam alat masih tidak ada pertumbuhan kuman, maka alat dinyatakan kedaluwarsa setelah lebih dari 6 bulan disterilisasi.
- Tidak ada penggunaan alat kesehatan *single use* yang digunakan ulang oleh pasien.
4. Obat risiko tinggi (*high risk*) dan elektrolit konsentrat
- Obat risiko tinggi yaitu sediaan farmasi dengan zat aktif yang akan menimbulkan kematian atau kecatatan bila terjadi kesalahan (*error*) dalam penggunaannya. Obat risiko tinggi merupakan kategori obat *high alert* yang disimpan secara terpisah, tersorot lampu, dan dibatasi dengan label berwarna merah serta diberi label “*High Alert*”.
- Elektrolit konsentrat disimpan dengan lokasi akses terbatas dalam lemari khusus dan dibatasi dengan label berwarna merah. Penyimpanan elektrolit konsentrat di Instalasi Farmasi diberi stiker “High Alert”, “encerkan”, dan “LASA”. Penyimpanan elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih. Unit perawatan yang diperbolehkan untuk penyimpanan elektrolit konsentrat yaitu IGD, ICU, PICU, Maternitas, IKO, dan ambulance. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien harus diletakkan pada *box/trolley/kit emergency* dilengkapi dengan segel pengaman untuk menghindari kesalahan, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati.
- Elektrolit konsentrat merupakan salah satu obat *emergency* dimana dibutuhkan akses cepat dan obat harus siap pakai bila sewaktu-waktu diperlukan dan tersedia di berbagai unit pelayanan, seperti obat untuk mengatasi syok anafilaktik di tempat penyuntikan, dan obat untuk pemulihan anestesi ada di kamar operasi. Pemilihan

elektrolit konsentrat berdasarkan kondisi klinis dan telah berkoordinasi dengan staf medis. Elektrolit konsentrat yang telah dipilih dibuatkan daftar yang mencakup nama obat, dosis, jumlah, keterangan kadaluarsa dan disimpan dalam *box/trolley/kit emergency*.

5. Reagensia

Rumah sakit menetapkan reagensia esensial yang ada untuk pelayanan laboratorium bagi pasien. Semua reagensia disimpan dan didistribusikan sesuai prosedur yang ditetapkan. Penyimpanan reagensia esensial disimpan dalam suatu lemari dengan suhu penyimpanan sesuai yang disarankan oleh produsen, semua reagensia esensial disimpan dan diberi label. Tempat penyimpan harus bersih, kering, jauh dari sumber panas matahari, dan dilengkapi dengan ventilasi yang menuju keluar ruangan. Penataan reagensia dikelompokkan berdasarkan stabilitas suhu penyimpanan dan tingkat risiko bahaya (*multiple hazards*). Penyimpanan reagensia dilengkapi dengan data *Material Safety Data Sheet* (MSDS). Evaluasi/audit penyimpanan reagensia esensial dilakukan oleh supervisi apoteker untuk memastikan akurasi dan presisi hasil pemeriksaan, antara lain untuk aspek penyimpanan, label yang lengkap dan akurat, kedaluwarsa dan fisik.

6. Gas Medis

Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Gas medis disimpan terpisah dari tempat sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai lainnya yang dilengkapi APAR, bebas dari sumber api, berventilasi baik, dan dilengkapi dengan troli pengaman untuk menghindari tabung terguling, serta diberi penanda label. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya.

7. B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Bahan berbahaya dan beracun disimpan dalam lemari khusus dimana tersedia APAR dan diberi label B3 sesuai sifat dan risiko bahan agar dapat mencegah staf dan lingkungan dari risiko terpapar bahan berbahaya dan beracun atau mencegah terjadinya bahaya seperti kebakaran. Bahan kimia yang terbuka diberi label yang secara jelas dan terbaca.

8. Penggunaan obat tertentu

Beberapa macam obat memerlukan ketentuan khusus untuk menyimpan dan mengawasi penggunaannya seperti :

a. Produk nutrisi

Produk nutrisi enteral maupun parenteral disimpan dengan baik dan benar sesuai dengan instruksi penyimpanan yang tertera dari produsen.

b. Obat dan bahan radioaktif (belum tersedia di RS Prima Husada)

c. Obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit

Semua obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit harus dicatat dalam formulir catatan riwayat penggunaan obat dan berita acara serah terima obat yang dibawa dari rumah kemudian obat disimpan pada keranjang pasien obat dari rumah di depo farmasi sesuai dengan stabilitas penyimpanan.

d. Obat dan bahan medis habis pakai dari program atau bantuan pemerintah

- Obat yang diberi oleh pemerintah (obat hibah) di Rumah Sakit Prima Husada adalah obat TBC, antivirus covid-19, vaksin covid-19, obat KB, vaksin imunisasi dasar yang disimpan dengan baik, benar, dan aman sesuai dengan stabilitasnya.

- Bahan medis habis pakai yang diberi oleh pemerintah (BMHP hibah) di Rumah Sakit Prima Husada adalah spuit, masker, alcohol swab, hazmat yang disimpan dengan baik, benar, dan aman sesuai dengan stabilitasnya.
- e. Obat digunakan untuk penelitian (belum tersedia di RS Prima Husada)

9. *Box/trolley/kit emergency*

Pengelolaan obat *emergency* tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan. Penyimpanan disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan.

Dilakukan supervisi oleh apoteker terhadap penyimpanan obat *emergency* dan segera diganti apabila dipakai, kedaluwarsa, atau rusak. Pelaksanaan supervisi dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengecekan segel, pengecekan kedaluwarsa di list daftar obat dan pengecekan suhu penyimpanan dilakukan setiap hari.
- b. Pengecekan jumlah dan dipakai dilakukan saat segel terbuka.
- c. Pengecekan obat yang mendekati ED (*expired date*) 6 bulan segera diganti dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk mencegah kedaluwarsa saat dibutuhkan.

10. Penyimpanan *Floorstock*

Penyimpanan sediaan farmasi dengan *Floorstock* dilakukan pada ruangan Instalasi Kamar Operasi (IKO), Maternitas, dan ponok IGD dengan jenis dan jumlah obat terbatas sesuai ketentuan.

Pengawasan Penyimpanan Obat

Selain adanya sistem penyimpanan yang baik, dibuat pula sistem pengawasan obat, dengan tujuan agar sediaan farmasi terlindung dari kehilangan dan pencurian, yaitu dengan cara internal dan eksternal.

Sistem pengawasan internal meliputi :

1. Melakukan pencatatan pada kartu stok setiap pengambilan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. *Random stock* setiap pergantian shift oleh kepala jaga.
Random stock adalah kegiatan melakukan pengecekan stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara random dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian untuk memastikan stok fisik sesuai dengan kartu stok dan *billing* SIM-RS.
3. Melakukan kegiatan stok opname setiap satu bulan sekali.
4. Memiliki sistem IT inventori obat.

Sistem pengawasan eksternal meliputi :

1. Memasang CCTV di area penyimpanan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. Membuat peringatan tertulis "Selain Petugas Farmasi, Dilarang Masuk."
3. Terdapat *fingerprint* untuk memastikan bahwa hanya petugas farmasi yang diperbolehkan masuk area Instalasi Farmasi.

Obat yang disimpan diluar Instalasi Farmasi (obat dalam *box/trolley/kit emergency*) dilakukan supervisi apoteker secara teratur memastikan penyimpanan obat dilakukan dengan baik mencakup :

1. Stabilitas suhu penyimpanan
2. Tanggal kedaluwarsa

3. Jumlah
4. Pelabelan LASA, *High Alert*, dan Encerkan
5. Kondisi segel

5.3.2 Penarikan dan Pemusnahan

Rumah Sakit memiliki sistem penarikan kembali, pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai tidak layak digunakan karena rusak, mutu substandar, atau kedaluwarsa, dicabut izin edarnya. Rumah sakit menjamin bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak layak pakai karena rusak, mutu substandar, atau kedaluwarsa, dicabut izin edarnya tidak digunakan serta dimusnahkan.

Tujuan dilakukan pemusnahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan.
2. Untuk menghindari pembiayaan seperti biaya penyimpanan, pemeliharaan, penjagaan atas obat atau perbekalan kesehatan lainnya yang sudah tidak layak untuk dipelihara.
3. Untuk menjaga keselamatan kerja dan menghindarkan diri dari pengotoran lingkungan, dan penyalahgunaan. Pembuangan yang tidak layak dapat menjadi berbahaya jika kemudian menimbulkan kontaminasi pada sumber air setempat. Selain itu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kedaluwarsa dapat disalahgunakan dan digunakan kembali jika tempat pembuangan tidak dipilih secara tepat dan aman.

Prosedur pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditanam atau dengan cara lain. Pada proses pemusnahan sediaan farmasi, prosedur yang dapat digunakan pada sediaan tablet dengan cara merendam tablet tersebut hingga hancur dan pada sediaan cair seperti sirup dan injeksi dilakukan dengan mengaliri sediaan tersebut sehingga sediaan tersebut habis terbuang, sedangkan proses pemusnahan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai prosedur yang dipilih adalah dengan insenerasi, yakni memasukkan perbekalan kesehatan ke dalam pembakaran bersuhu tinggi (800°C).

Prosedur pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan oleh apoteker pengelola atau apoteker pengganti dibantu minimal 1 Tenaga Vokasi Farmasi. Tahap–tahap proses pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai adalah:

1. Inventarisasi terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan.
2. Persiapan administrasi, meliputi laporan dan berita acara pemusnahan.
3. Penentuan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan dan koordinasi dengan pihak terkait.
4. Persiapan tempat pemusnahan.
5. Pelaksanaan pemusnahan, menyesuaikan jenis dan bentuk sediaan.
6. Pembuatan laporan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan, nama dan jumlah yang dimusnahkan, nama apoteker pelaksana pemusnahan, nama saksi dalam pelaksanaan pemusnahan.
7. Laporan pemusnahan ditandatangani oleh apoteker dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan.

Pengelolaan terhadap vaksin covid-19 yang rusak dan/atau kedaluwarsa, melakukan tahapan berikut :

- a. Pemisahan, Pengumpulan, dan Penandaan pada vaksin covid-19 yang rusak dan/atau telah memasuki masa kedaluwarsa dengan langkah sebagai berikut :
 - 1. Mencoret *barcode* atau informasi lain yang menyertai vaksin sehingga tidak berpotensi untuk disalahgunakan.



Gambar 2. Contoh Pencoretan pada Barcode Vial Vaksin



Gambar 3. Contoh Pencoretan pada Informasi Vaksin

- 2. Masukkan vaksin yang masih berada di dalam vial/ampul tersebut ke dalam wadah atau plastik yang tahan terhadap kebocoran dan beri label “Vaksin Rusak dan/atau Kedaluwarsa”, dilengkapi dengan identitas Rumah Sakit Prima Husada.
- 3. Vaksin tersebut harus disimpan di tempat yang terlindung dari paparan sinar matahari secara langsung, terlindung dari hujan dan sumber air lainnya, terlindung dari hewan pengerat, terpisah dari makanan untuk menghindari kontaminasi, serta akses dibatasi hanya pada personil dan pejabat yang berwenang untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, pencurian, dan/atau risiko lainnya yang mungkin terjadi.
- b. Pencatatan pada menu Pembuangan di aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE).
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait rencana waktu pengiriman/ penerimaan vaksin tersebut yang dilengkapi dengan Berita Acara.

Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri.

5.4 Peresepan dan Penyalinan

5.4.1 Peresepan

Rumah sakit menetapkan dan menerapkan peresepan/ permintaan obat dan bmhp/ instruksi pengobatan yang benar, lengkap, dan terbaca. Rumah sakit menetapkan dan melatih tenaga medis yang kompeten dan berwenang untuk melakukan peresepan/ permintaan obat dan bmhp/ instruksi pengobatan. Untuk menghindari keragaman dan mencegah kesalahan obat yang berdampak pada keselamatan pasien, maka rumah sakit menetapkan persyaratan bahwa semua resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan harus mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter.

Persyaratan kelengkapan lain ditambahkan disesuaikan dengan jenis resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan meliputi :

1. Data identitas pasien secara akurat
Data identitas pasien secara akurat berupa stiker dan sudah terintegrasi dengan SIM-RS sehingga dapat menjamin kebenaran identitas lebih akurat.
2. Elemen pokok pada resep/ permintaan obat/ instruksi pengobatan.
Elemen pokok pada resep meliputi persyaratan administrasi, farmasetik, dan klinis.
3. Penggunaan nama dagang atau generik
Peresepan dokter di RS Prima Husada melalui *e-resep*, sehingga dokter dapat langsung menentukan nama dagang atau generik. Penggunaan nama dagang dan generik sebagai berikut :
 - a. Peresepan pada pasien BPJS mendapatkan obat generik sesuai instruksi Dokter dan tersedia di Formularium Nasional.
 - b. Peresepan pada pasien UMUM/ BPJS naik kelas VVIP/ asuransi lain mendapatkan obat generik dan/atau paten sesuai instruksi Dokter.
4. Penggunaan indikasi dan dosis maksimal sehari pada obat PRN (*pro re nata* atau “jika perlu”) atau instruksi pengobatan lain. Penulisan k/p, atau prn harus disertai dengan indikasi penggunaan atau kapan diperlukannya, misalnya : prn sakit kepala atau prn mual. Kemudian disertakan dosis maksimal untuk pemakaian satu hari.
5. Jenis instruksi pengobatan yang berdasar atas berat badan seperti untuk anak-anak, lansia yang rapuh, dan populasi khusus sejenis lainnya.
6. Kecepatan pemberian infus di instruksi pengobatan. Kecepatan pemberian infus harus tertulis pada peresepan infus.
7. Instruksi khusus, seperti : titrasi, *tapering off*, *standing order*, *automatic stop order*, rentang dosis.

Instruksi titrasi adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat dinaikkan/ diturunkan secara bertahap tergantung status klinis pasien. Instruksi harus terdiri dari: dosis awal, dosis titrasi, parameter penilaian, dan titik akhir penggunaan.

Intruksi *tapering off* adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat diturunkan secara berahap sampai akhirnya dihentikan. Cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi efek yang tidak diharapkan akibat penghentian mendadak. Instruksi harus rinci dituliskan tahapan penurunan dosis dan waktunya.

Standing order adalah suatu instruksi dokter yang ditujukan kepada perawat atau professional kesehatan lain untuk memberikan intervensi kepada pasien selama dokter tidak ada di tempat.

Automatic stop order diterapkan pada obat-obatan kategori tertentu yang dianggap sebagai obat yang kuat/ poten dan obat-obat yang memerlukan review regular. Misal : antiinfeksi, antivirus, antifungi, narkotik, dan kortikosteroid. Jadi, pengobatan atau peresepan yang tidak disebutkan secara khusus tentang jumlah obat atau lama hari pengobatan, maka akan dikenai kebijakan *automatic stop order*. Pengobatan harus diresepkan untuk jangka waktu yang jelas, bukan menggunakan perkiraan waktu (misal: “dilanjutkan hingga pemberitahuan berikutnya” atau “dilanjutkan hingga pasien dipulangkan”

Instruksi rentang dosis adalah instruksi pengobatan dimana dosis obat dinyatakan dalam rentang. Dosis disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien.

Ditetapkan proses untuk menangani atau mengelola hal-hal di bawah ini:

- Resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak terbaca.
- Resep atau permintaan obat dan instruksi pengobatan yang NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) atau LASA (Look Alike Sound Alike).
- Jenis resep khusus, seperti emergensi, cito, berhenti otomatis (*automatic stop order*), *tapering*, dan lainnya.

- Instruksi pengobatan secara lisan atau melalui telepon wajib dilakukan tulis lengkap, baca ulang, dan meminta konfirmasi

Daftar obat yang diresepkan tercatat dalam rekam medis pasien yang mencantumkan identitas pasien, nama obat, dosis, rute pemberian, waktu pemberian, nama dan tanda tangan dokter. Daftar ini menyertai pasien ketika dipindahkan sehingga professional pemberi asuhan (PPA) yang merawat pasien dengan mudah dapat mengakses informasi tentang penggunaan obat pasien. Daftar obat pulang diserahkan kepada pasien disertai edukasi penggunaannya agar pasien dapat menggunakan obat dengan benar dan mematuhi aturan pakai yang sudah ditetapkan.

5.4.2 Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat

Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat yang pernah dan sedang digunakan, riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medis/ pencatatan penggunaan obat pasien.

Tahapan penelusuran riwayat penggunaan obat :

1. Membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam medik/ pencatatan. penggunaan obat untuk mengetahui kemungkinan perbedaan informasi penggunaan obat.
2. Melakukan verifikasi riwayat penggunaan obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain dan memberikan informasi tambahan jika diperlukan.
3. Mendokumentasikan adanya alergi, efek samping obat (ESO) dan reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD).
4. Mengidentifikasi kesesuaian indikasi obat, bentuk sediaan, dosis, dan frekuensi penggunaan.
5. Mengidentifikasi potensi teradinya interaksi obat.
6. Melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam menggunakan obat
7. Melakukan penilaian rasionalitas obat yang diresepkan.
8. Menanyakan harapan dan tanggapan pasien tentang pengobatan dan penyakit atau gangguan yang dialami.
9. Melakukan penilaian terhadap pemahaman pasien terhadap obat yang digunakan.
10. Melakukan penilaian adanya kemungkinan penyalahgunaan obat.
11. Melakukan penilaian terhadap teknik penggunaan obat.
12. Memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap obat dan alat bantu kepatuhan minum obat.
13. Mendokumentasikan obat yang digunakan pasien sendiri.
14. Mengidentifikasi terapi lain, misalnya suplemen dan pengobatan alternatif yang mungkin digunakan oleh pasien.

Informasi yang harus diperhatikan :

1. Nama pasien, alamat, usia, jenis kelamin, pekerjaan, berat badan, tinggi badan, keyakinan, tanggapan, harapan dan keluhan.
2. Nama obat, dosis, bentuk sediaan, frekuensi penggunaan, indikasi dan lama penggunaan obat, data hasil pemeriksaan laboratorium, dan data hasil pemeriksaan fisik pasien.
3. Informasi reaksi obat yang tidak dikehendaki termasuk riwayat alergi.
4. Kepatuhan terhadap regimen penggunaan obat (jumlah obat yang tersisa).

Obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit berisiko dalam hal keaslian dan mutu obat. Oleh sebab itu rumah sakit melakukan penilaian terhadap obat tersebut terkait kelayakan penggunaannya di rumah sakit. Penggunaan obat oleh pasien secara mandiri (*self administration*), baik yang dibawa dari luar rumah sakit atau yang

diresepkan rumah sakit diketahui oleh dokter penanggung jawab pasien (DPJP) dan dicatat di rekam medis pasien.

Obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit dapat digunakan kembali berdasarkan *advice* dokter penanggung jawab pasien (DPJP) yang dikelola oleh Instalasi Farmasi. Apoteker menanyakan obat dari luar rumah sakit dilanjutkan atau dihentikan kepada DPJP dengan metode SBAR kemudian ditulis di Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Penggunaan obat yang dibawa oleh pasien dari luar rumah sakit didokumentasikan di formulir catatan riwayat penggunaan obat. Obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit yang dilanjutkan maka dilakukan pencatatan oleh apoteker pada berita acara penerimaan obat dan kartu stok, kemudian mencatat setiap penambahan terapi dan perubahan dosis pada lembar rekonsiliasi obat, serta mencatat obat di daftar pemberian obat (DPO) dan beri jam pemberian obat. Obat pasien yang dibawa dari luar rumah sakit disimpan pada keranjang pasien obat dari rumah di Depo Farmasi, kemudian sisa obat harus dikembalikan kepada pasien.

Penggunaan obat oleh pasien secara mandiri oleh pasien diperbolehkan oleh Rumah Sakit atas dasar kenyamanan pasien pada sediaan sirup, inhalasi, insulin, rectal, dan intravaginal. Petugas Instalasi Farmasi melakukan edukasi yang di buktikan mengisi hasil edukasi di dalam rekam medis pada formulir pemberian edukasi dan meminta persetujuan pasien dengan mengisi surat pernyataan pengobatan sendiri. Kemudian dilakukan pemantauan penggunaan dengan cara mengisi form monitoring pengobatan sendiri untuk menghindari obat yang tidak tepat.

5.4.3 Rekonsiliasi Obat

Rekonsiliasi obat yaitu proses membandingkan daftar obat yang digunakan oleh pasien sebelum dirawat inap dengan peresepan/ permintaan obat dan instruksi pengobatan. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat. Pencatatan pada rekonsiliasi obat adalah :

1. Rekonsiliasi awal medis yaitu pertama kali sejak pasien masuk dinyatakan rawat inap dilakukan di IGD oleh apoteker yang bertugas. Data rekonsiliasi obat yang ditulis adalah obat yang digunakan pasien di IGD, dan alergi pasien terhadap obat.
2. Rekonsiliasi transfer unit yaitu saat pemindahan pasien antar unit pelayanan dilakukan di ruang perawatan oleh apoteker yang bertugas. Data rekonsiliasi obat yang ditulis adalah obat-obatan yang digunakan pasien saat rawat inap.
3. Rekonsiliasi discharge yaitu sebelum pasien pulang oleh apoteker yang bertugas. Apoteker mengkaji obat yang dibawa pasien pulang dan membandingkannya dengan terapi saat di ruang perawatan.

Tujuan dilakukannya rekonsiliasi obat adalah:

1. Memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien.
2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter.
3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter.

Tahapan proses rekonsiliasi obat yaitu:

1. Pengumpulan data
Mencatat data dan verifikasi obat yang sedang dan akan digunakan pasien, meliputi nama obat, dosis, frekuensi, rute, obat mulai diberikan, diganti, dilanjutkan dan dihentikan, riwayat alergi pasien serta efek samping obat yang pernah terjadi. Khusus untuk data alergi dan efek samping obat, dicatat tanggal kejadian, obat yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi dan efek samping, efek yang terjadi, dan tingkat keparahan. Data riwayat penggunaan obat didapatkan dari pasien, keluarga pasien, daftar obat pasien, obat yang ada pada pasien. Data obat yang dapat digunakan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sebelumnya. Semua obat yang digunakan

oleh pasien baik resep maupun obat bebas termasuk herbal harus dilakukan proses rekonsiliasi.

2. Komparasi

Petugas kesehatan membandingkan data obat yang pernah, sedang dan akan digunakan. *Discrepancy* atau ketidakcocokan adalah bilamana ditemukan perbedaan diantara data-data tersebut. Ketidakcocokan dapat pula terjadi bila ada obat yang hilang, berbeda, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan yang didokumentasikan pada rekam medik pasien. Ketidakcocokan ini dapat bersifat disengaja oleh dokter pada saat penulisan resep maupun tidak disengaja dimana dokter tidak tahu adanya perbedaan pada saat menuliskan resep.

3. Melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan ketidaksesuaian dokumentasi.

Bila ada ketidaksesuaian, maka dokter harus dihubungi kurang dari 24 jam. Hal lain yang harus dilakukan oleh Apoteker adalah:

- a. Menentukan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau tidak disengaja.
- b. Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan, atau pengganti.
- c. Memberikan tanda tangan, tanggal, dan waktu dilakukannya rekonsiliasi obat.

4. Komunikasi

Melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga pasien atau perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi. Apoteker bertanggungjawab terhadap informasi obat yang diberikan.

5.5 Penyiapan dan Penyerahan

5.5.1 Penyiapan

Penyiapan (dispensing) adalah rangkaian proses mulai dari diterimanya resep/ permintaan obat/ intruksi pengobatan sampai dengan penyerahan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai kepada dokter/ perawat atau kepada pasien/keluarga. Penyiapan obat dilakukan oleh staf yang terlatih dalam lingkungan yang aman bagi pasien, staf, dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan dan standar praktik kefarmasian untuk menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat obat. Peraturan perundang-undangan dan praktik profesi seperti:

1. Pencampuran obat kemoterapi harus dilakukan di dalam ruang yang bersih (*clean room*) yang dilengkapi dengan *cytotoxic handling drug safety cabinet* dengan petugas sudah terlatih dengan teknik aseptik serta menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai (tidak tersedia obat kemoterapi di RS Prima Husada)
2. Pencampuran obat intravena, epidural, dan nutrisi parenteral serta pengemasan kembali obat suntik harus dilakukan dalam ruang yang bersih (*clean room*) yang dilengkapi dengan *laminary airflow cabinet* untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk serta melindungi petugas dari paparan zat berbahaya. Petugas pencampuran obat intravena secara aseptis menggunakan APD yang sesuai yang dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknik kefarmasian yang telah mengikuti pelatihan pencampuran obat injeksi secara aseptis (pencampuran obat intravena yang dilakukan di RS Prima Husada).

Kegiatan pencampuran obat intravena:

- a. Melakukan sterilisasi dan dekontaminasi terhadap LAF (selengkapnya pada SPO sterilisasi dan dekontaminasi LAF)
- b. Mencampur sediaan intravena ke dalam cairan yang sesuai
- c. Melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai

- d. Mengemas menjadi sediaan siap pakai disertai dengan etiket dilengkapi *Beyond of Use Date* (BUD) obat yang telah di rekonstitusi. Data stabilitas injeksi dapat dilihat selengkapnya pada Data Stabilitas Injeksi setelah direkonstitusi.
3. Proses produksi sediaan farmasi dilakukan oleh apoteker atau Tenaga Vokasi Farmasi yang terlatih. Staf yang menyiapkan produk steril terlatih dengan prinsip penyiapan obat dan teknik aseptis. Melakukan pencampuran obat intravena sesuai kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Pencampuran dilakukan di *Laminar Air Flow* (LAF) dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap obat, dosis, nama pasien, tanggal lahir. Pencampuran obat intravena dilakukan dengan memperhatikan stabilitas dari injeksi setelah di rekonstitusi untuk menjamin kestabilan obat injeksi. Pelaksanaan petugas yang menyiapkan produk steril didokumentasikan pada lembar absensi daftar hadir petugas pencampuran obat intravena.

Penyiapan obat dijelaskan sesuai prosedur yang telah ditetapkan selengkapnya pada Standar Prosedur Operasional Penyiapan Obat Rawat Inap dan Rawat Jalan. Rumah sakit menyediakan sistem komputerisasi untuk proses pengelolaan mutasi stok dan pencatatan pelayanan obat yang terintegrasi. Pengeluaran sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai hanya dapat dilayani ketika resep sudah diinput di *billing* SIM-RS.

Tabel 6. Daftar Stabilitas Obat Sesudah Dibuka

No	Formulasi	Rekomendasi
1.	Tablet/kapsul tanpa kemasan original	BUD = 1 tahun setelah tanggal dibuka (ED > 1 tahun) BUD = ED dari pabrik (ED < 1 tahun)
2.	Tablet/kapsul dengan kemasan original	Sesuai ED dari pabrik
3.	Sirup, emulsi, dan suspensi non rekonstitusi	BUD = 1 tahun setelah tanggal dibuka (ED > 1 tahun) BUD = ED dari pabrik (ED < 1 tahun)
4.	Krim/ Salep racikan	1 bulan setelah tanggal dibuka
5.	Krim/ Salep non racikan	BUD = 1 tahun setelah tanggal dibuka (ED > 1 tahun) BUD = ED dari pabrik (ED < 1 tahun)
6.	Suppositoria/ rektal tube/ inhaler	Sesuai ED dari pabrik
7.	Tetes/ spray hidung dan telinga	3 bulan setelah tanggal dibuka
8.	Tetes mata	30 hari setelah tanggal dibuka
9.	Insulin	28 hari setelah dibuka/dipakai
10.	Puyer/kapsul	BUD = 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED (ED > 6 bulan). Jika hasilnya < 6 bulan, maka BUD maksimal = hasil perhitungan tersebut. Jika > 6 bulan, maka BUD maksimal = 6 bulan. BUD = ED dari pabrik (ED < 6 bulan)
11.	Sirup, emulsi, dan suspensi rekonstitusi	1. Larutan yang mengandung air, BUD maksimal = 14 hari. 2. Larutan yang tidak mengandung air : BUD = 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED (ED > 6 bulan).

		Jika hasilnya < 6 bulan, maka BUD maksimal = hasil perhitungan tersebut. Jika > 6 bulan, maka BUD maksimal = 6 bulan. BUD = ED dari pabrik (ED < 6 bulan)
12	Tetes mata mini dose (MDS)	2 hari setelah tanggal dibuka
13	Tetes mata botol	30 hari setelah tanggal dibuka

5.5.2 Pengkajian dan Pelayanan Resep

Pengkajian resep adalah kegiatan menelaah resep sebelum obat disiapkan, yang meliputi pengkajian aspek administratif, farmasetik, dan klinis. Pengkajian resep dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang kompeten dan diberi kewenangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat sebelum obat disiapkan.

Pengkajian resep meliputi :

NO.	TELAAH ADMINISTRASI	LENGKAP	
		YA	TIDAK
1.	Nama, umur, jenis kelamin, BB, TB pasien		
2.	Nama, nomor ijin, alamat, dan paraf		
3.	Tanggal resep		
4.	Ruangan asal resep		

NO.	TELAAH FARMASETIK	YA	TIDAK
1.	Nama obat, bentuk, dan kekuatan sediaan		
2.	Dosis dan jumlah obat		
3.	Stabilitas		
4.	Aturan dan cara penggunaan		

NO.	TELAAH KLINIS	YA	TIDAK
1.	Ketepatan indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat		
2.	Duplikasi pengobatan		
3.	Alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki		
4.	Kontra indikasi		
5.	Interaksi obat		
6.	Polifarmasi		
Nama & TTD Petugas :			

Dalam pengkajian resep Tenaga Vokasi Farmasi diberi kewenangan terbatas hanya aspek administrasi dan farmasetik.

Pengkajian resep aspek klinis yang baik oleh Apoteker memerlukan data klinis pasien, sehingga Apoteker harus diberi kemudahan akses untuk mendapatkan informasi klinis pasien.

5.5.3 Telaah Obat

Apoteker/ Tenaga Vokasi Farmasi harus melakukan telaah obat sebelum obat diserahkan kepada perawat/ pasien.

Untuk memastikan bahwa obat yang sudah disiapkan tepat :

- a. Pasien
- b. Nama obat
- c. Dosis dan jumlah obat

- d. Rute pemberian
- e. Waktu pemberian

5.5.4 Konseling

Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien atau keluarga. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif Apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan/atau keluarga terhadap apoteker.

Pemberian konseling Obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD), dan meningkatkan costeffectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan Obat bagi pasien (patient safety).

Tujuan :

1. Meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien.
2. Menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien.
3. Membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat.
4. Membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya.
5. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.
6. Mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat.
7. Meningkatkan kemampuan pasien memecahkan masalahnya dalam hal terapi.
8. Mengerti permasalahan dalam pengambilan keputusan.
9. Membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien.

Kegiatan :

1. Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien.
2. Mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui *Three Prime Questions* yakni :
 - a. Apakah yang disampaikan dokter tentang obat Anda?
 - b. Apakah dokter menjelaskan tentang cara pemakaian obat Anda?
 - c. Apakah dokter menjelaskan tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut?
3. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat.
4. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat.
5. Melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman pasien.
6. Dokumentasi

Faktor yang perlu diperhatikan :

1. Ruang konseling
2. Alat bantu konseling
3. Sumber Daya Manusia
4. Kriteria Pasien :
 - a. Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati dan ginjal, ibu hamil dan menyusui).
 - b. Pasien dengan terapi jangka panjang/ penyakit kronis (TB, DM, epilepsi,dll).
 - c. Pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus (penggunaan kortikosteroid dengan *tapering down /off*).
 - d. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit (digoksin,

- phenytoin).
- e. Pasien yang menggunakan banyak obat > 5 macam obat (polifarmasi).
- f. Pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah.

5.6 Pemberian Obat

Pemberian obat untuk pengobatan pasien memerlukan pengetahuan spesifik dan pengalaman. Rumah sakit bertanggung jawab menetapkan staf klinis dengan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan, memiliki izin, dan sertifikat berdasar atas peraturan perundang-undangan untuk memberikan obat. Rumah sakit dapat membatasi kewenangan individu dalam melakukan pemberian obat, seperti pemberian obat narkotika dan psikotropika, radioaktif, atau obat penelitian. Dalam keadaan darurat maka rumah sakit dapat menetapkan tambahan staf klinis yang diberi izin memberikan obat.

Pada proses pemberian obat di rawat inap dilakukan batasan terhadap bidan/perawat. Obat oral di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1. Obat injeksi di rawat inap diadministrasikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang terlatih. Vaksin boleh diberikan oleh bidan/ perawat minimal PK 1 yang diberi mandat oleh dokter yang bersangkutan dan sudah terlatih. Elektrolit konsentrat dan injeksi sedasi ringan hanya diberikan oleh perawat minimal PK 2 yang terlatih atau perawat penanggungjawab shift. Pemberian obat dalam sendi dan intrathecal hanya dilakukan oleh DPJP yang terlatih dan memiliki sertifikasi.

Sebelum pemberian obat kepada pasien dilakukan verifikasi kesesuaian obat dengan instruksi pengobatan yang meliputi :

1. Benar identitas pasien
2. Benar nama obat
3. Benar dosis
4. Benar rute pemberian
5. Benar waktu pemberian

Rumah sakit menetapkan ketentuan yang digunakan untuk verifikasi pemberian obat. Jika obat disiapkan dan diserahkan di unit rawat inap pasien maka verifikasi harus juga dilakukan oleh orang yang kompeten. Terhadap obat yang harus diwaspadai (*high alert*) harus dilakukan *double check* oleh minimal 2 orang.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu dengan memberikan pelayanan 24 jam. Pendistribusian adalah kegiatan mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis.

Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan :

1. Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada.
2. Metode sentralisasi atau desentralisasi.
3. Sistem "*floor stock*", resep individu, dispensing dosis unit atau kombinasi.

Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat inap merupakan kegiatan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat inap di rumah sakit, yang diselenggarakan secara sentralisasi dengan sistem dispensing dosis unit/ *unit dose dispensing* dan sistem kombinasi oleh farmasi.

Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien rawat jalan merupakan kegiatan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat jalan dirumah sakit, yang diselenggarakan secara sentralisasi dengan sistem resep perorangan oleh farmasi rumah sakit. Sistem pelayanan distribusi :

1. Sistem persediaan di ruangan (*floorstock*)

Instalasi yang memiliki *floorstock* adalah Instalasi Kamar Operasi, Maternitas, dan Ponsek IGD. Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk persediaan di ruang rawat merupakan tanggungjawab perawat ruangan. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan tidak dalam jumlah besar maksimal 20 unit dan dapat dikontrol secara berkala oleh petugas farmasi. Perawat penanggungjawab di instalasi yang memiliki sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ikut melakukan *stock opname* di tanggal akhir bulan bersama dengan petugas Instalasi Farmasi. Alur *floor stock* dijelaskan selengkapnya pada Panduan *Floorstock*.

2. *Box/trolley/kit emergency*

Sediaan farmasi dan alat kesehatan *emergency* di ruangan, disimpan dalam *box/trolley/kit emergency* yang dikelola dan dimonitor oleh Instalasi Farmasi. Unit/Instalasi yang memiliki *box/trolley/kit emergency* adalah instalasi rawat inap, instalasi kamar operasi, radiologi, ICU, PICU, IGD, ruang *treadmill*, poli Lantai 1, poli lantai 2, dan poli vaksin .

Pengelolaan *box/trolley/kit emergency* harus menjamin jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat *emergency* yang telah ditetapkan, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain, bila dipakai untuk keperluan *emergency* harus segera diganti, dicek secara berkala apakah ada yang kedaluwarsa, dan dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.

Elektrolit konsentrat diluar Instalasi Farmasi diperbolehkan hanya dalam situasi klinis yang berisiko dan harus memenuhi persyaratan yaitu staf yang dapat mengakses dan memberikan elektrolit konsentrat adalah staf yang kompeten dan terlatih serta disimpan dalam *box/trolley/kit emergency* tersegel. Elektrolit konsentrat yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati. *Box/trolley/kit emergency* diletakkan di tempat yang mudah diakses (*nurse station*), siap pakai dan hanya boleh dibuka pada keadaan *emergency*. *Box/trolley/kit emergency* hanya boleh dibuka oleh petugas farmasi, perawat, bidan dan dokter pada saat kejadian pasien, penunggu /pengunjung, staf rumah sakit yang tiba-tiba mengalami kondisi gawat darurat. Penggunaan stok di *box/trolley/kit emergency* harus disertai resep dokter. Penggantian di *box/trolley/kit emergency* dilakukan 5 menit setelah adanya laporan ke unit farmasi rawat inap oleh unit terkait yang membuka *box/trolley/kit emergency*.

Pengecekan *box/trolley/kit emergency* dilakukan setiap hari oleh perawat/bidan ruangan pada saat pergantian *shift*. Pemantauan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk *box/trolley/kit emergency* dilakukan dengan supervisi apoteker.

3. Sistem resep perorangan

Resep perorangan adalah order/ resep yang ditulis dokter untuk tiap pasien. Dalam sistem ini resep disiapkan dan didistribusikan oleh instalasi farmasi sesuai yang

tertulis pada resep. Resep perorangan akan dikaji langsung oleh apoteker, yang kemudian memberikan keterangan atau informasi kepada pasien secara langsung sehingga memberikan kesempatan interaksi profesional apoteker dan pasien yang memungkinkan pengendalian yang lebih dekat.

4. Sistem *dispensing* dosis unit/ *Unit Dose Dispensing*

Pendistribusian obat-obatan melalui resep perorangan yang disiapkan, diberikan dalam unit dosis tunggal atau ganda, yang berisi obat dalam jumlah yang telah ditetapkan atau jumlah yang cukup untuk penggunaan satu kali dosis. Penyaluran obat rawat inap tepat waktu tercatat dalam Daftar Pemberian Obat. Alur sistem unit dosis dijelaskan selengkapnya pada Panduan *Unit Dose Dispensing* (UDD).

Jadwal pemberian obat injeksi dan obat oral di Rumah Sakit Prima Husada, meliputi:

Tabel 7. Waktu Pemberian untuk Obat Oral

Aturan Pakai	Waktu Pemberian
Signa satu kali sehari*	07.00 / 12.00 / 17.00
Signa dua kali sehari*	07.00 – 17.00
Signa tiga kali sehari*	07.00 – 12.00 – 17.00
Signa empat kali sehari*	06.00 – 12.00 – 18.00 – 23.00
Signa lima kali sehari*	06.00 – 11.00 – 16.00 – 21.00 – 02.00
Signa empat kali sehari*	06.00 – 10.00 – 14.00 – 18.00 – 22.00 – 02.00

*dan atau sesuai dengan instruksi Dokter atau rekomendasi Apoteker setelah melakukan pengkajian terhadap obat pasien.

Tabel 8. Waktu Pemberian untuk Obat Injeksi

Aturan Pakai	Waktu Pemberian
Signa satu kali sehari*	08.00/ 16.00/ 20.00/ 24.00
Signa dua kali sehari*	08.00 dan 20.00
Signa tiga kali sehari*	08.00, 16.00, dan 24.00
Signa empat kali sehari*	06.00, 12.00, 18.00, dan 23.00

*dan atau sesuai dengan instruksi Dokter atau rekomendasi Apoteker setelah melakukan pengkajian terhadap obat pasien.

Untuk obat-obatan selain sediaan oral dan injeksi, diberikan sesuai dengan instruksi dari Dokter dan atau saran Apoteker setelah pengkajian terhadap obat.

5.7 Pemantauan

5.7.1 Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

Standar ini bertujuan agar apabila timbul efek samping obat dapat dilaporkan oleh profesional pemberi asuhan (PPA) kepada Komite Farmasi dan Terapi yang selanjutnya dilaporkan pada Pusat MESO Nasional. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respons tubuh yang tidak dikehendaki terhadap obat yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. (ROTD) (*ADR, adverse drug reactions*) sebagai respons yang tidak dapat diperkirakan. yang tidak dikehendaki atau respons yang berlebihan akibat penggunaan obat sehingga muncul reaksi alergi atau reaksi idiosinkrasi.

Pelaporan ESO dan ROTD dapat dilakukan oleh petugas yang pertama kali menemukan adanya ESO dan ROTD (apoteker, perawat, ataupun Tenaga Vokasi

Farmasi). Laporan ESO dan ROTD dilaporkan kepada apoteker penanggungjawab masing-masing ruangan rawat inap yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Komite Farmasi dan Terapi RS Prima Husada.

Tujuan :

2. Menentukan ESO (Efek Samping Obat) sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal, frekuensinya jarang.
3. Menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal sekali, yang baru saja ditemukan.
4. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan/mempengaruhi timbulnya ESO atau mempengaruhi angka kejadian hebatnya ESO.
5. Meminimalkan risiko kejadian Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki.
6. Mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki.

Kegiatan :

1. Mendeteksi adanya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki (ESO).
2. Mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami ESO.
3. Menganalisa laporan ESO.
4. Mengisi formulir ESO (lihat di lembar pelaporan ESO).
5. Melaporkan ke Tim MESO dan ROTD.

Faktor yang perlu diperhatikan :

1. Kerjasama dengan Panitia Farmasi dan Terapi dan ruang rawat.
2. Ketersediaan formulir Monitoring ESO.

5.7.2 Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Apoteker mengevaluasi efek obat untuk memantau secara ketat respons pasien dengan melakukan pemantauan terapi obat (PTO). Apoteker bekerjasama dengan pasien, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk memantau pasien yang diberi obat. Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. PTO dilakukan oleh apoteker penanggungjawab masing-masing ruangan rawat inap dan didokumentasikan di lembar Pemantauan Terapi Obat Rumah Sakit Prima Husada.

Kegiatan :

1. Pengkajian pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respons terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD).
2. Pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat.
3. Pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat.

Tahapan Pemantauan Terapi Obat :

1. Seleksi pasien.

Pemantauan terapi obat (PTO) seharusnya dilaksanakan untuk seluruh pasien. Mengingat terbatasnya jumlah apoteker dibandingkan dengan jumlah pasien, maka perlu ditentukan prioritas pasien yang akan dipantau. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan:

a. Kondisi Pasien.

- Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima polifarmasi.
- Pasien kanker yang menerima terapi sitostatika.
- Pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal.
- Pasien geriatri dan pediatri.

- Pasien hamil dan menyusui.
 - Pasien dengan perawatan intensif.
 - b. Obat
 - Pasien yang menerima obat dengan risiko tinggi seperti : obat dengan indeks terapi sempit (contoh: digoksin, fenitoin) ; obat yang bersifat nefrotoksik (contoh: gentamisin) dan hepatotoksik (contoh: OAT); sitostatika (contoh: metotreksat); antikoagulan (contoh: warfarin, heparin) ; obat yang sering menimbulkan ROTD (contoh: metoklopramid, AINS); obat kardiovaskular (contoh: nitrogliserin).
 - Kompleksitas regimen seperti polifarmasi, variasi rute pemberian, variasi aturan pakai, dan cara pemberian khusus (contoh: inhalasi)
2. Pengumpulan data pasien.
- Data dasar pasien merupakan komponen penting dalam proses PTO. Data tersebut dapat diperoleh dari:
- a. Rekam medik.
 - b. Profil pengobatan pasien/pencatatan penggunaan obat.
 - c. Wawancara dengan pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lain.
- Rekam medik merupakan kumpulan data medik seorang pasien mengenai pemeriksaan, pengobatan dan perawatannya di rumah sakit. Data yang dapat diperoleh dari rekam medik, antara lain:
- a. Data demografi pasien
 - b. Keluhan utama
 - c. Riwayat penyakit sekarang
 - d. Riwayat penyakit terdahulu
 - e. Riwayat penggunaan obat
 - f. Riwayat keluarga,
 - g. Riwayat sosial
 - h. Pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnostik, diagnosis dan terapi.
- Data tersebut di pelayanan komunitas dapat diperoleh melalui wawancara dengan pasien, meskipun data yang diperoleh terbatas. Profil pengobatan pasien di rumah sakit dapat diperoleh dari kartu penggunaan obat. Profil tersebut mencakup data penggunaan obat rutin, obat p.r.n (obat jika perlu), obat dengan instruksi khusus (contoh: insulin). Semua data yang sudah diterima, dikumpulkan dan kemudian dikaji. Data yang berhubungan dengan PTO diringkas dan diorganisasikan ke dalam suatu format yang sesuai. Seringkali data yang diperoleh dari rekam medis dan profil pengobatan pasien belum cukup untuk melakukan PTO, oleh karena itu perlu dilengkapi dengan data yang diperoleh dari wawancara pasien, anggota keluarga, dan tenaga kesehatan lain.
3. Identifikasi masalah terkait obat.
- Setelah data terkumpul, perlu dilakukan analisis untuk identifikasi adanya masalah terkait obat. Masalah terkait obat menurut Hepler dan Strand dapat dikategorikan sebagai berikut:
- a. Ada indikasi tetapi tidak di terapi
 - Pasien yang diagnosis telah ditegakkan dan membutuhkan terapi obat tetapi tidak diresepkan. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua keluhan/gejala klinik harus diterapi dengan obat.
 - b. Pemberian obat tanpa indikasi
 - Pasien mendapatkan obat yang tidak diperlukan.
 - c. Pemilihan obat yang tidak tepat.
 - Pasien mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya (bukan merupakan pilihan pertama, obat yang tidak *cost effective*, kontra indikasi.
 - d. Dosis terlalu tinggi

- e. Dosis terlalu rendah
- f. Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD)
- g. Interaksi obat
- h. Pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab

Beberapa penyebab pasien tidak menggunakan obat antara lain: masalah ekonomi, obat tidak tersedia, ketidakpatuhan pasien, kelalaian petugas. Apoteker perlu membuat prioritas masalah sesuai dengan kondisi pasien, dan menentukan masalah tersebut sudah terjadi atau berpotensi akan terjadi. Masalah yang perlu penyelesaian segera harus diprioritaskan.

4. Rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat.

Tujuan utama pemberian terapi obat adalah peningkatan kualitas hidup pasien, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyembuhkan penyakit (contoh: infeksi)
- b. Menghilangkan atau mengurangi gejala klinis pasien (contoh: nyeri)
- c. Menghambat progresivitas penyakit (contoh: gangguan fungsi ginjal)
- d. Mencegah kondisi yang tidak diinginkan (contoh: stroke).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan tujuan terapi adalah derajat keparahan penyakit dan sifat penyakit (akut atau kronis). Pilihan terapi dari berbagai alternatif yang ada ditetapkan berdasarkan: efikasi, keamanan, biaya, regimen yang mudah dipatuhi.

Faktor yang harus diperhatikan:

- a. Kemampuan penelusuran informasi dan penilaian kritis bukti terkini dan terpercaya.
- b. Kerahasiaan informasi.
- c. Kerjasama dengan tim kesehatan lain (dokter dan perawat).

5. Pemantauan.

Setelah ditetapkan pilihan terapi maka selanjutnya perlu dilakukan perencanaan pemantauan, dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Apoteker dalam membuat rencana pemantauan perlu menetapkan langkah-langkah:

a. Menetapkan parameter farmakoterapi

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih parameter pemantauan, antara lain:

- Karakteristik obat (contoh: sifat nefrotoksik dari allopurinol, aminoglikosida). Obat dengan indeks terapi sempit yang harus diukur kadarnya dalam darah (contoh: digoksin).
- Efikasi terapi dan efek merugikan dari regimen
- Perubahan fisiologik pasien (contoh: penurunan fungsi ginjal pada pasien geriatri mencapai 40%).
- Efisiensi pemeriksaan laboratorium
- Kepraktisan pemantauan (contoh: pemeriksaan kadar kalium dalam darah untuk penggunaan furosemide dan digoxin secara bersamaan)
- Ketersediaan (pilih parameter pemeriksaan yang tersedia),
- Biaya pemantauan.

b. Menetapkan sasaran terapi (*end point*)

Penetapan sasaran akhir didasarkan pada nilai/gambaran normal atau yang disesuaikan dengan pedoman terapi. Apabila menentukan sasaran terapi yang diinginkan, apoteker harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Faktor khusus pasien seperti umur dan penyakit yang bersamaan diderita pasien (contoh: perbedaan kadar teofilin pada pasien Penyakit Paru Obstruksi Kronis/ PPOK dan asma)

- Karakteristik obat
Bentuk sediaan, rute pemberian, dan cara pemberian akan mempengaruhi sasaran terapi yang diinginkan (contoh: perbedaan penurunan kadar gula darah pada pemberian insulin dan anti diabetes oral).
- Efikasi dan toksisitas
- c. Menetapkan frekuensi pemantauan
Frekuensi pemantauan tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan risiko yang berkaitan dengan terapi obat. Sebagai contoh pasien yang menerima obat kanker harus dipantau lebih sering dan berkala dibanding pasien yang menerima aspirin. Pasien dengan kondisi relatif stabil tidak memerlukan pemantauan yang sering. Berbagai faktor yang mempengaruhi frekuensi pemantauan antara lain:
 - Kebutuhan khusus dari pasien
Contoh: penggunaan obat nefrotoksik pada pasien gangguan fungsi ginjal.
 - Karakteristik obat pasien
Contoh: pasien yang menerima warfarin
 - Biaya dan kepraktisan pemantauan
Permintaan tenaga kesehatan lain

Data pasien yang lengkap mutlak dibutuhkan dalam PTO, tetapi pada kenyataannya data penting terukur sering tidak ditemukan sehingga PTO tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan penggunaan data subyektif sebagai dasar PTO. Jika parameter pemantauan tidak dapat digantikan dengan data subyektif maka harus diupayakan adanya data tambahan. Proses selanjutnya adalah menilai keberhasilan atau kegagalan mencapai sasaran terapi. Keberhasilan dicapai ketika hasil pengukuran parameter klinis sesuai dengan sasaran terapi yang telah ditetapkan. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka dapat dikatakan mengalami kegagalan mencapai sasaran terapi. Penyebab kegagalan tersebut antara lain: kegagalan menerima terapi, perubahan fisiologis/kondisi pasien, perubahan terapi pasien, dan gagal terapi. Salah satu metode sistematis yang dapat digunakan dalam PTO adalah *Subjective Objective Assessment Planning (SOAP)*.

6. Tindak lanjut.

Hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan terkait. Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terapi. Informasi dari dokter tentang kondisi pasien yang menyeluruh diperlukan untuk menetapkan target terapi yang optimal. Komunikasi yang efektif dengan tenaga kesehatan lain harus selalu dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah baru.

Kegagalan terapi dapat disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dan kurangnya informasi obat. Sebagai tindak lanjut pasien harus mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara tepat. Informasi yang tepat sebaiknya:

- Tidak bertentangan/berbeda dengan informasi dari tenaga kesehatan lain,
- Tidak menimbulkan keraguan pasien dalam menggunakan obat.
- Dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat,

5.7.3 Visite

Visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan

reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta professional kesehatan lainnya. Visite dilakukan kepada setiap pasien rawat inap di RS dan di dokumentasikan di rekam medis pasien. Visite dilakukan untuk meminimalisir terjadinya *medication error* dan meningkatkan keberhasilan terapi pada pasien rawat inap.

Tujuan :

1. Pemilihan obat
2. Menerapkan secara langsung pengetahuan farmakologi terapeutik
3. Menilai kemajuan pasien
4. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain

Kegiatan :

1. Apoteker harus memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan tersebut kepada pasien.
2. Untuk pasien baru dirawat, Apoteker menanyakan terapi obat terdahulu dan memperkirakan masalah yang mungkin terjadi.
3. Melakukan pengkajian terhadap catatan perawat tentang daftar pemberian obat pasien guna mengkaji obat yang diterima oleh pasien.
4. Apoteker mencatat perkembangan pasien dan masalah terkait pengobatan di lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) Rawat Inap.

Faktor – faktor yang perlu diperhatikan :

1. Pengetahuan cara berkomunikasi
2. Memahami teknik edukasi
3. Mencatat perkembangan pasien

Persiapan Praktik Visite :

1. Seleksi pasien
Seharusnya layanan visite diberikan kepada semua pasien yang masuk rumah sakit. Namun mengingat keterbatasan jumlah apoteker maka layanan visite diprioritaskan untuk pasien dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pasien baru (dalam 24 jam pertama).
 - b. Pasien dalam perawatan intensif.
 - c. Pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat.
 - d. Pasien yang mengalami penurunan fungsi organ terutama hati dan ginjal.
 - e. Pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai penurunan kadar albumin.
 - f. Pasien yang mendapatkan obat yang mempunyai indeks terapeutik sempit, berpotensi menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) yang fatal. Contoh: pasien yang mendapatkan terapi obat digoksin, karbamazepin, teofilin, sitostatika.
2. Pengumpulan informasi penggunaan obat
Informasi penggunaan obat dapat diperoleh dari rekam medik, wawancara dengan pasien /keluarga, catatan pemberian obat. Informasi tersebut meliputi :
 - a. Data pasien
Nama, nomor rekam medis, tanggal lahir/umur, jenis kelamin, berat badan (BB), tinggi badan (TB), ruang rawat, nomor tempat tidur, sumber pembiayaan.
 - b. Keluhan utama
Keluhan / kondisi pasien yang menjadi alasan untuk dirawat.
 - c. Riwayat penyakit saat ini (*history of present illness*)

-
- Riwayat keluhan/ keadaan pasien berkenaan dengan penyakit yang di deritanya saat ini.
- d. Riwayat sosial
Kondisi sosial (gaya hidup) dan ekonomi pasien yang berhubungan dengan penyakitnya. Contoh : pola makan, merokok, minuman keras, perilaku seks bebas, pengguna narkoba, tingkat pendidikan, penghasilan.
 - e. Riwayat penyakit terdahulu
Riwayat singkat penyakit yang pernah di derita pasien, tindakan dan perawatan yang pernah diterimanya yang berhubungan dengan penyakit pasien saat ini.
 - f. Riwayat penyakit keluarga
Adanya keluarga yang menderita penyakit yang sama atau berhubungan dengan penyakit yang sedang dialami pasien. Contoh : hipertensi, diabetes, jantung, kelainan darah, kanker.
 - g. Riwayat penggunaan obat
Daftar obat yang pernah digunakan pasien sebelum dirawat (termasuk obat bebas, obat tradisional dan lama penggunaan obat
 - h. Riwayat alergi / ROTD, daftar obat yang pernah menimbulkan reaksi alergi atau ROTD.
 - i. Pemeriksaan fisik
Tanda-tanda vital (temperatur, tekanan darah, nadi, kecepatan pernapasan), kajian sistem organ (kardiovaskuler, ginjal, hati).
 - j. Pemeriksaan laboratorium
Data hasil pemeriksaan laboratorium diperlukan dengan tujuan: menilai apakah diperlukan terapi obat, penyesuaian dosis, menilai efek terapeutik obat, menilai adanya ROTD, mencegah terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya : akibat sampel sudah rusak, kuantitas sampel tidak cukup, sampel diambil pada waktu yang tidak tepat, prosedur tidak benar, reagensia yang digunakan tidak tepat, kesalahan teknis oleh petugas, interaksi dengan makanan / obat. Apoteker harus dapat menilai hasil pemeriksaan pasien dan membandingkannya dengan nilai normal.
 - k. Pemeriksaan diagnostik
Foto roentgen, USG, CT Scan. Data hasil pemeriksaan diagnostik diperlukan dengan tujuan: menunjang penegakan diagnosis, menilai hasil terapeutik pengobatan, menilai adanya risiko pengobatan.
 - l. Masalah medis meliputi gejala dan tanda klinis, diagnosis utama dan penyerta.
 - m. Catatan penggunaan obat saat ini adalah daftar obat yang sedang digunakan oleh pasien.
 - n. Catatan perkembangan pasien adalah kondisi klinis pasien yang diamati dari hari ke hari.
3. Pengkajian masalah terkait obat
Pasien yang mendapatkan obat memiliki risiko mengalami masalah terkait penggunaan obat baik yang bersifat aktual (yang nyata terjadi) maupun potensial (yang mungkin terjadi). Masalah terkait penggunaan obat antara lain : efektivitas terapi, efek samping obat, biaya. Penjelasan rinci tentang klasifikasi masalah terkait obat lihat lampiran.
4. Fasilitas
Fasilitas praktik visite antara lain:
- a. Formulir pemantauan obat
 - b. Referensi dapat berupa cetakan atau elektronik, misalnya: Formularium Nasional, Formularium Rumah Sakit, Pedoman Penggunaan Antibiotika, Pedoman Diagnosis dan Terapi, *Formulary Services (AHFS): Drug Information*, Pedoman Terapi, dll.

c. Kalkulator

Pelaksanaan Visite :

Kegiatan visite dapat dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing (lihat tabel) yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan visite dan menetapkan rekomendasi.

Kegiatan visite mandiri

Kelebihan	Kekurangan
- Waktu visite disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang lain	- Rekomendasi yang dibuat terkait peresepan tidak dapat segera di implementasikan sebelum bertemu dengan dokter penulis resep
- Melakukan konseling, monitoring respon pasien terhadap pengobatan	- Pemahaman tentang patofisiologi penyakit pasien terbatas
- Dapat dilakukan sebagai persiapan untuk visite bersama dengan tim	

Kegiatan visite tim :

Kelebihan	Kekurangan
- Dapat memperoleh informasi terkini yang komprehensif	- Jadwal visite harus disesuaikan dengan tim
- Sebagai fasilitas pembelajaran	- Waktu pelaksanaan visite terbatas sehingga diskusi dan penyampaian informasinya kurang lengkap
- Dapat langsung mengkomunikasikan masalah terkait penggunaan obat dan mengimplementasikan rekomendasi yang dibuat	

Visite Mandiri :

1. Memperkenalkan diri kepada pasien
Pada kegiatan visite mandiri, apoteker harus memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya agar timbul kepercayaan mereka terhadap profesi apoteker sehingga mereka dapat bersikap terbuka dan kooperatif. Contoh cara memperkenalkan diri, “Selamat pagi /siang/sore Ibu/Bapak, Saya...(sebutkan nama), apoteker di ruang rawat...(sebutkan nama ruang rawat tempat anda melakukan visite). Bagaimana keadaan Ibu hari ini ? Membaik ? Atau ada keluhan lain ?”. Pada tahap ini, apoteker dapat menilai adanya hambatan pasien dalam berkomunikasi dan status klinis pasien (misalnya: kesadaran, kesulitan berbicara, dll).
2. Mendengarkan respon yang disampaikan oleh pasien dan identifikasi masalah terkait obat
Setelah memberikan salam, apoteker berkomunikasi efektif secara aktif untuk menggali permasalahan pasien terkait penggunaan obat. Respon dapat berupa keluhan yang disampaikan oleh pasien, misalnya : rasa nyeri menetap / bertambah, sulit buang air besar; atau adanya keluhan baru, misalnya: gatal-gatal, mual, pusing. Apoteker harus melakukan kajian untuk memastikan apakah keluhan tersebut terkait dengan penggunaan obat yang telah diberitahukan sebelumnya, misalnya urin berwarna merah karena penggunaan rifampisin; mual karena penggunaan siprofloksasin atau metformin.

Setelah bertemu dengan pasien, berdasarkan informasi yang diperoleh, apoteker dapat menetapkan status masalah (aktual atau potensial), dan mengidentifikasi adanya masalah baru.

3. Memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat

Pada visite mandiri, rekomendasi lebih ditujukan kepada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan obat dalam hal aturan pakai, acara pakai, dan hal-hal yang harus diperhatikan selama menggunakan obat. Rekomendasi kepada pasien yang dilakukan oleh apoteker dapat berupa konseling, edukasi, dan pendampingan cara penggunaan obat.

Setelah pelaksanaan visite mandiri, apoteker dapat menyampaikan rekomendasi kepada perawat tentang jadwal dan cara pemberian obat, misalnya: obat diberikan pada waktu yang telah ditentukan (interval waktu pemberian yang sama), pemberian obat sebelum / sesudah makan, selang waktu pemberian obat untuk mencegah terjadinya interaksi, kecepatan infus, jenis pelarut yang digunakan, stabilitas dan ketercampuran obat suntik. Rekomendasi kepada perawat yang dilakukan oleh apoteker dapat berupa konseling, edukasi, dan pendampingan cara penyiapan obat.

Rekomendasi yang diberikan harus berdasarkan pada bukti terbaik, terpercaya dan terkini agar diperoleh hasil terapi yang optimal. Rekomendasi kepada apoteker lain dapat dilakukan dalam proses penyiapan obat, misalnya: kalkulasi dan penyesuaian dosis, pengaturan jalur dan laju infus. Rekomendasi kepada dokter yang merawat yang dilakukan oleh apoteker dapat berupa diskusi pembahasan masalah dan kesepakatan keputusan terapi.

4. Melakukan pemantauan implementasi rekomendasi

Apoteker harus memantau pelaksanaan rekomendasi kepada pasien, perawat, atau dokter. Jika rekomendasi belum dilaksanakan maka apoteker harus menelusuri penyebab tidak dilaksanakannya rekomendasi dan mengupayakan penyelesaian masalah. Contoh: pasien minum siprofloksasin bersama dengan antasida karena sudah terbiasa minum semua obat setelah makan atau minum siprofloksasin bersama dengan susu. Seharusnya siprofloksasin diminum dengan selang waktu 2 jam sebelum minum antasida/susu. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberi edukasi kepada perawat/ pasien tentang adanya interaksi antara siprofloksasin dan antasida/susu membentuk kompleks yang menyebabkan penyerapan siprofloksasin terganggu dan efektivitas siprofloksasin berkurang.

5. Melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat

Pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat dilakukan dengan menggunakan metode *Subject-Object-Assessment-Plan* (SOAP).

Subjektif adalah semua keluhan yang dirasakan pasien.

Objektif adalah hasil pemeriksaan yang dapat diukur, misalnya temperatur, tekanadarah, kadar glukosa darah, kreatinin serum, bersihan kreatinin, jumlah leukosit dalam darah, dll.

Assessment adalah penilaian penggunaan obat pasien (identifikasi masalah terkait obat).

Plan adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan *assessment* yang dilakukan. Apoteker juga harus memantau hasil rekomendasi dengan mengamati kondisi klinis pasien baik yang terkait dengan efektivitas terapi maupun efek samping obat. Contoh: efektivitas antibiotika dapat dinilai dari perbaikan tanda-tanda infeksi setelah 48-72 jam, misalnya: demam menurun ($36,5-37^{\circ}\text{C}$), jumlah leukosit mendekati nilai normal ($5000-10.000 \times 10^9/\text{L}$); sedangkan efek samping antibiotika, misalnya: diare, mual.

Visite Tim :

1. Memperkenalkan diri kepada pasien dan atau tim

Pada kegiatan visite bersama dengan tenaga kesehatan lain, pengenalan anggota tim kepada pasien dan keluarganya dilakukan oleh ketua tim visite.

2. Mengikuti dengan seksama presentasi kasus yang disampaikan
Pada saat mengunjungi pasien, dokter yang merawat akan memaparkan perkembangan kondisi klinis pasien berdasarkan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan wawancara dengan pasien; hal ini dapat dimanfaatkan apoteker untuk memperbarui data pasien yang telah diperoleh sebelumnya atau mengkaji ulang permasalahan baru yang timbul karena perubahan terapi. Apoteker harus berpartisipasi aktif dalam menggali latar belakang permasalahan terkait penggunaan obat. Contoh: keluhan pasien berupa sulit buang air besar dapat disebabkan oleh imobilitas atau efek samping obat, misalnya codein.
3. Memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat
Sebelum memberikan rekomendasi, apoteker berdiskusi dengan anggota tim secara aktif untuk saling mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan melengkapi informasi penggunaan obat. Pada visite tim, rekomendasi lebih ditujukan kepada dokter yang merawat dengan tujuan untuk meningkatkan hasil terapi, khususnya dalam pemilihan terapi obat, misalnya pemilihan jenis dan rejimen antibiotika untuk terapi demam tifoid, waktu penggantian antibiotika injeksi menjadi antibiotika oral, lama penggunaan antibiotika sesuai pedoman terapi yang berlaku. Rekomendasi yang diberikan harus berdasarkan informasi dari pasien, pengalaman klinis (kepakaran) dokter dan bukti terbaik yang dapat diperoleh. Rekomendasi tersebut merupakan kesepakatan penggunaan obat yang terbaik agar diperoleh hasil terapi yang optimal. Pemberian rekomendasi kepada dokter yang merawat dikomunikasikan secara efektif, misalnya: saran tertentu yang bersifat sensitif (dapat menimbulkan kesalahpahaman) diberikan secara pribadi (tidak di depan pasien / perawat).
4. Melakukan pemantauan implementasi rekomendasi
Setelah rekomendasi disetujui dokter yang merawat untuk diimplementasikan, apoteker harus memantau pelaksanaan rekomendasi perubahan terapi pada rekam medik dan catatan pemberian obat. Jika rekomendasi belum dilaksanakan maka apoteker harus menelusuri penyebabnya dan mengupayakan penyelesaian masalah. Contoh: jika saran untuk mengganti Antibiotika injeksi menjadi antibiotika oral setelah 2 hari suhu tubuh pasien normal tidak dilaksanakan (dapat diketahui dari rekam medik / catatan pemberian obat) maka apoteker harus menelusuri penyebabnya. Contoh penyebabnya: dokter belum memberikan instruksi, obat tidak tersedia, perawat belum memberikan. Apoteker dapat mengingatkan dokter tentang penggantian bentuk sediaan antibiotika.
5. Melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat
Pemantauan efektivitas dan keamanan penggunaan obat berupa keluhan pasien, manifestasi klinis, dan hasil pemeriksaan penunjang; dapat dilakukan dengan menggunakan metode SOAP. Contoh: pemberian insulin harus dipantau secara ketat untuk penyesuaian dosis (target kadar glukosa darah tercapai) dan menghindari terjadinya hipoglikemia; pada penggunaan Kaptopril, apoteker memperhatikan penurunan tekanan darah pasien sebagai indikator efektivitas terapi dan menanyakan keluhan batuk kering sebagai indikator ROTD.

5.7.4 Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

Evaluasi penggunaan obat merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif untuk menjamin obat-obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien. Pengkajian penggunaan antibiotik dilakukan di RS Prima Husada kepada pasien rawat inap dan rawat jalan. Penggunaan antibiotik setiap pasien di RS Prima Husada

dilakukan pencatatan dan pengkajian lebih lanjut oleh apoteker penanggungjawab masing-masing ruangan.

Tujuan EPO yaitu :

1. Mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat dan antibiotik pada pelayanan kesehatan/ dokter tertentu.
2. Membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu.
3. Memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat.
4. Menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat.

Kegiatan praktek EPO :

1. Mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif.
2. Mengevaluasi penggunaan obat secara kuantitatif.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan :

1. Indikator persepsian.
2. Indikator pelayanan.
3. Indikator fasilitas.

5.8 Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien di Rumah Sakit. PIO dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengobatan karena berkembangnya penelitian tentang obat-obatan secara terus-menerus kepada tenaga medis lain dan pasien.

Tujuan :

1. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan dilingkungan rumah sakit.
2. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai terutama bagi Komite Farmasi dan Terapi.
3. Meningkatkan profesionalisme apoteker.
4. Menunjang penggunaan obat yang rasional.

Kegiatan :

1. Menjawab pertanyaan
2. Membuat buletin, leaflet, label obat, poster secara berkala.
3. Menyediakan informasi bagi Komite Farmasi dan Terapi sehubungan dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit
4. Bersama dengan Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap
5. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga farmasi dan tenaga kesehatan lainnya
6. Mengkoordinasi penelitian tentang obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian.

Faktor-faktor yang diperhatikan :

1. Sumber daya manusia.
2. Sumber informasi obat.
3. Tempat.
4. Perlengkapan.

5.9 Pengendalian

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pengendalian penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi harus bersama dengan Komite Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit.

Tujuan pengendalian persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai adalah untuk :

1. Penggunaan Obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit,
2. Penggunaan Obat sesuai dengan diagnosis dan terapi,
3. Memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.

Instalasi farmasi melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (*slow moving*), evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan berturut-turut (*death stock*), dan *stok opname* yang dilakukan secara periodik dan berkala.

Kegiatan pengendalian mencakup:

1. Memperkirakan dan menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu. Jumlah stok ini disebut stok kerja.
2. Menentukan stok optimum adalah stok obat yang diserahkan kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan/kekosongan.
3. Menentukan waktu tunggu (*lead time*) adalah waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai obat diterima.

Selain itu, beberapa pengendalian yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut:

1. Daftar pemberian obat
Daftar pemberian obat adalah formulir yang digunakan perawat untuk menyiapkan obat sebelum pemberian. Pada formulir ini perawat memeriksa obat yang akan diberikan pada pasien. Dengan formulir ini perawat dapat langsung merekam/mencatat waktu pemberian dan aturan yang sebenarnya sesuai petunjuk. Apoteker melakukan *double check* Daftar Pemberian Obat sebelum obat diberikan kepada pasien.
2. Pengembalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak digunakan
Semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang belum diberikan kepada pasien rawat inap harus tetap berada dalam kotak obat. Pengembalian (retur obat) pasien pulang segera dikembalikan oleh perawat yang bersangkutan kepada instalasi farmasi. Hanya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dalam kemasan tersegel yang dapat dikembalikan ke instalasi farmasi.
3. Pengendalian obat dalam kamar operasi dan ruang rawat inap
Sistem pengendalian obat rumah sakit harus sampai ke kamar operasi. Apoteker harus memastikan bahwa semua obat yang digunakan dalam bagian ini tepat order, disimpan, disiapkan, dan dipertanggungjawabkan sehingga pencatatan dilakukan seperti pencatatan di instalasi farmasi. Pemantauan yang terkait dengan instalasi farmasi tercantum dalam supervisi apoteker.

5.10 Administrasi

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan untuk memonitor jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang keluar dan masuk di instalasi farmasi. Adanya pencatatan berfungsi untuk pertanggungjawaban bagi petugas instalasi farmasi serta memudahkan petugas untuk melakukan penelusuran bila terjadi adanya mutu sediaan farmasi yang sub standar dan harus ditarik dari peredaran.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pencatatan:

1. Pencatatan data dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu secara *real time* saat pelayanan obat.
2. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan.

Informasi yang diperoleh dari pencatatan kartu stok meliputi jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tersedia, diterima, keluar, hilang/ rusak/ kedaluwarsa, serta jangka waktu kekosongan.

Manfaat pencatatan yang dilakukan meliputi :

1. Untuk mengetahui dengan cepat jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
2. Penyusunan laporan.
3. Perencanaan pengadaan dan distribusi serta pengendalian persediaan.
4. Untuk pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan pendistribusian.
5. Sebagai alat bantu kontrol bagi kepala instalasi farmasi.

Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi, tenaga, dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan pelaporan agar tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi, tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran surat dan laporan, mendapat data yang lengkap untuk membuat perencanaan.

Jenis laporan yang dibuat oleh Instalasi Farmasi meliputi:

1. Laporan Harian (laporan rekapan harian, laporan insiden keselamatan pasien, laporan indikator mutu, laporan rapor dokter).
2. Laporan Bulanan (laporan penggunaan obat narkotik dan psikotropik, laporan jadwal dinas tenaga kefarmasian, laporan stok opname, laporan bulanan unit).
3. Laporan Tahunan (laporan kajian sistem pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat, laporan evaluasi kinerja individu).

BAB VI

LOGISTIK

Tabel 9. Daftar Logistik yang terdapat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Prima Husada

No.	Jenis Logistik	Uraian
1.	Sediaan Farmasi	
2.	Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai	
3.	Peralatan Meracik	Timbangan analitik digital Timbangan neraca obat Mortir Stamper Alat cetak kapsul Gelas Ukur <i>Pressing machine puyer</i> <i>Plastic spoon puyer</i> <i>Tablet crusher – mesin pulverizer</i>
4.	Alat Tulis dan Kantor	Buku tulis Lem Isolasi kertas Isolasi bening Isolasi merah Staples Pelubang kertas Dispenser isolasi besar Isi staples Gunting Spidol Kertas 3 ply prs Kertas 3 ply non prs Kertas 2 ply prs Kertas 1 ply Kertas thermal ukuran 57x50 Bolpoint hitam Bolpoint merah Stabilo Box file Penggaris Map transparan Map bussines file Map holder – Inter X Kursi kantor hitam + pegangan Meja Lemari besi 2 pintu
5.	Inventaris lain	Box paket Dispenser Barcode scanner 207 BT Printer thermal zebra ZD888 Plastik klip 10x7 cm bening Plastik klip 10x7 cm merah Plastik klip 10x7 cm biru Plastik ½ kg Plastik ¼ kg Plastik 1 kg

		Pot salep 50 g Sabun cuci tangan Sendok obat Tissue kotak Kresek hitam Kresek putih Keranjang A3 280x166x120 Keranjang A4 325x240x130 Botol handsrub <i>Cold box vaccine carrier</i> <i>Cooler bag</i> Freeze tag Komputer Printer thermal TMT82X Printer dotmatrix Telepon AC + remote Microphone Kamera CCTV TV Rak obat Palet obat Tangga Lemari B3 Lemari narkotik dan psikotropika Tempat Sampah Footstep <i>Trolley obat</i> <i>Trolley infus</i> Tangga Kursi plastik Wastafel Keramik Kipas angin
6.	Dokumen tertulis	Resep Surat pesanan narkotik Etiket Rekonstitusi (Rawat Inap) Pengkajian resep ISO MIMS
7.	Alat	<i>Laminar Air Flow</i> <i>Showcase</i> Vaccine Refrigerator Negative Ion Air Purifier Thermohygro ruangan Thermohygro kulkas Thermometer analog muller Thermometer Digital Logtag Tablet Samsung Tatakan Tablet <i>Smart door lock (Fingerprint)</i>

BAB VII

KESELAMATAN PASIEN

7.1 Pengertian

1. Keselamatan Pasien RS adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut meliputi assessmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
2. Medication error adalah suatu kesalahan dalam proses pengobatan yang masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab profesi kesehatan, pasien atau konsumen, dan seharusnya dapat dicegah.
3. Manajemen risiko adalah suatu metode yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan mengkomunikasikan risiko yang ada pada suatu kegiatan.
4. Insiden Keselamatan Pasien (IKP) adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi.
5. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan ("commission") atau karena tidak bertindak ("omission"), bukan karena "underlying disease" atau kondisi pasien.
6. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah suatu Insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien.
7. Kejadian Tidak Cedera (KTC) adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak menimbulkan cedera, dapat terjadi karena "keberuntungan" (misal; pasien terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat), atau "peringanan" (suatu obat dengan reaksi alergi diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan anti-dotumnya).
8. Kondisi Potensial Cedera (KPC) adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden.
9. Kejadian Sentinel (Sentinel Event) adalah suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti: operasi pada bagian tubuh yang salah. Pemilihan kata "sentinel" terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (misalnya Amputasi pada kaki yang salah, dan sebagainya) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku.
10. Laporan insiden keselamatan pasien RS (Internal) Pelaporan secara tertulis setiap kejadian nyaris cedera (KNC) atau kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian tidak cedera (KTC) atau kondisi potensial cedera (KPC) yang menimpa pasien.

7.2 Kategori Medication Error

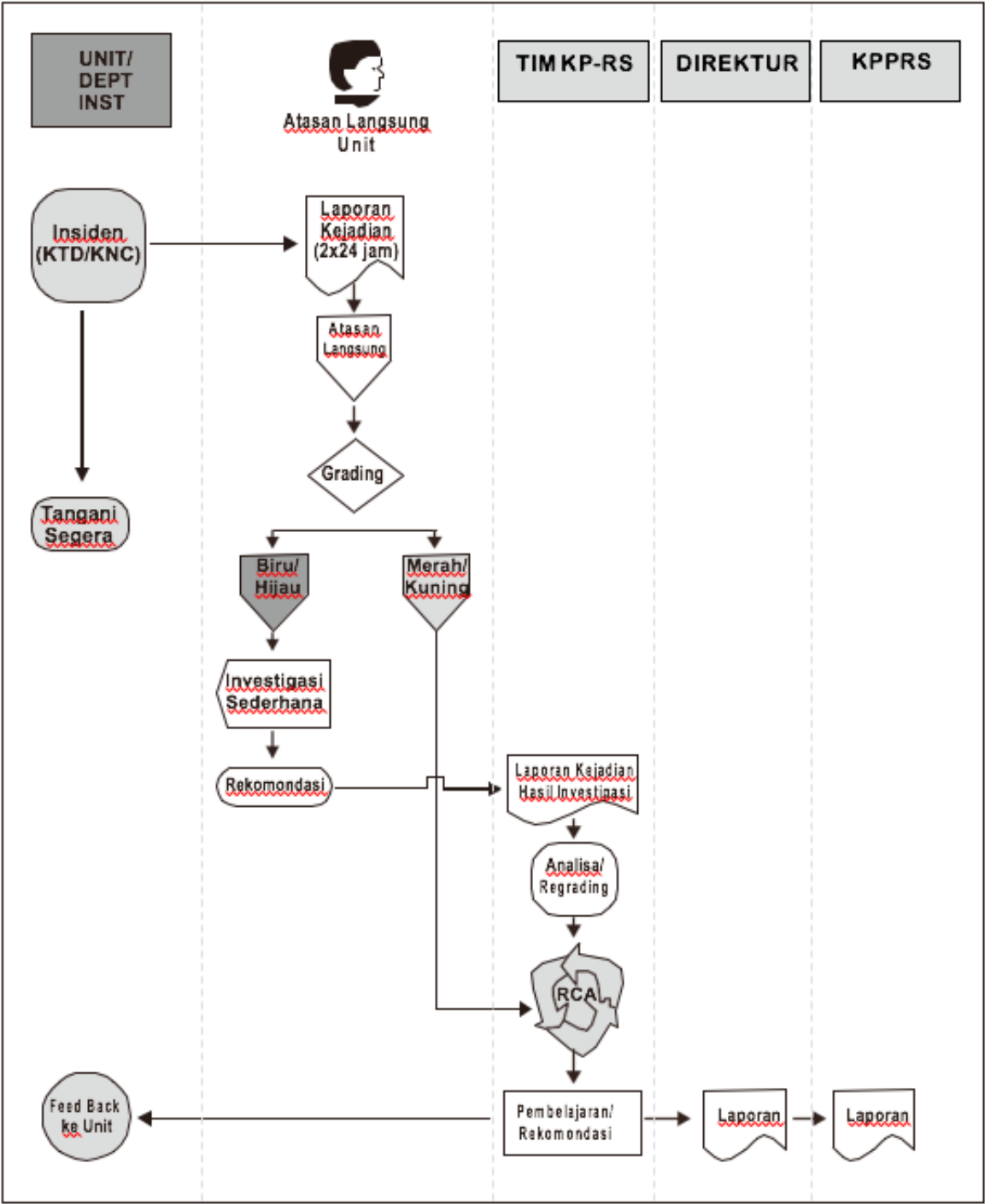
Idealnya setiap KTD/ KNC/ Kejadian Sentinel yang terkait dengan penggunaan obat harus dikaji terlebih dahulu oleh apoteker yang berpengalaman sebelum diserahkan kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Tujuan pengkajian untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah sesuai, nama obat yang dilaporkan benar, dan memasukkan dalam kategori insiden yang benar. Kategori kesalahan dalam pemberian obat di Instalasi Farmasi adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Kategori Kesalahan dalam Pemberian Obat di Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi	Kejadian kesalahan penyiapan obat	KPC/ KTC/ KTD
	Kejadian kesalahan penempelan label pada obat LASA	KPC
	Kejadian kesalahan pemberian obat	KPC/ KTC/ KTD
	Kejadian kesalahan penulisan etiket obat	KPC/ KTC/ KTD
	Kejadian ketidakpatuhan penempelan label obat <i>high alert</i>	KPC
	kejadian kesalahan input e-resep	KNC/ KTD
	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat jalan	KTC/ KTD
	Insiden kelebihan/ kekurangan penyerahan obat pada pasien rawat inap	KTC/ KTD
	Insiden reaksi alergi obat	KTD
	Obat tidak dilengkapi <i>expired date/ beyond use date</i>	KPC
	Obat LASA/ <i>High Alert</i> yang tidak disimpan pada tempatnya	KPC
	Insiden kesalahan pembacaan resep	KNC/ KTD
	Tulisan tangan yang tidak terbaca pada penulisan	KPC
	Persediaan obat-obatan emergency yang tidak lengkap	KPC
	Kesalahan identitas pasien pada <i>e-resep</i>	KPC

7.3 Alur Pelaporan Insiden ke Tim Keselamatan Pasien (KP) di Rumah Sakit

1. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/ KTD/ Kejadian Sentinel) terkait dengan pelayanan kefarmasian, wajib segera ditindaklanjuti (dicegah/ ditangani) untuk mengurangi dampak/ akibat yang tidak diharapkan.
2. Setelah ditindaklanjuti, segera buat laporan insidennya dengan mengisi Formulir Laporan Insiden pada akhir jam kerja/ shift kepada apoteker penanggung jawab dan jangan menunda laporan (paling lambat 2 x 24 jam).
3. Laporan segera diserahkan kepada apoteker penanggung jawab
4. Apoteker penanggungjawab memeriksa laporan dan melakukan *grading risiko* terhadap insiden yang dilaporkan.
5. Hasil *grading* akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang akan dilakukan.
6. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan ke Tim KP di RS.
7. Tim KP di RS akan menganalisis kembali hasil investigasi dan Laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan *Root Cause Analysis* (RCA) dengan melakukan *Regrading*.
8. Untuk Grade kuning/merah, Tim KP di RS akan melakukan *Root Cause Analysis* (RCA).
9. Setelah melakukan *Root Cause Analysis* (RCA), Tim KP di RS akan membuat laporan dan Rekomendasi untuk perbaikan serta “pembelajaran” berupa : Petunjuk / *Safety alert* untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
10. Hasil *Root Cause Analysis* (RCA), rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan kepada Direksi.
11. Rekomendasi untuk “Perbaikan dan Pembelajaran” diberikan umpan balik kepada instalasi farmasi.
12. Apoteker penanggungjawab akan membuat analisis dan tren kejadian disatuan kerjanya.
13. Monitoring dan evaluasi perbaikan oleh Tim KP di RS.



Gambar 4. Alur Pelaporan Insiden

7.4 Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

Tabel 11. Petunjuk Pengisian Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

DATA PASIEN		
Nama Pasien		(bisa diisi initial misal: Tn. AR, atau NY. SY) No.RM: (jelas)
Ruangan		Diisi nama ruangan dan nomor kamar misal: R. Melati/301
Data Pasien		1. Umur (bulan dan tahun (jelas)). 2. Kelompok Umur (Pilih salah satu (jelas)). 3. Jenis Kelamin (Pilih salah satu (jelas)). 4. Penanggung biaya pasien (Pilih salah satu (jelas)). 5. Tgl/jam MRS (jelas). (lihat=Lampiran Formulir Laporan IKP).
RINCIAN KEJADIAN		
Tanggal dan waktu insiden		1. Diisi tanggal dan waktu saat insiden (KTD/KNC/KTC/ KPC) terjadi. 2. Buat prosedur pelaporan agar tanggal dan waktu insiden tidak lupa: insiden harus dilaporkan paling lambat 1 x 24 jam atau pada akhir jam kerja/ shift.
Insiden		Salah identifikasi pasien, salah pemberian obat, salah dosis obat, dll.
Grading Risiko		hijau/biru/kuning/merah
Kronologis		1. Diisi ringkasan insiden mulai saat sebelum kejadian sampai terjadinya insiden. 2. Kronologis harus sesuai kejadian yang sebenarnya, bukan pendapat / asumsi pelapor.
Jenis insiden		Pilih salah satu Insiden Keselamatan Pasien (IKP) KTD/ KNC/ KTC/ KPC. Untuk laporan eksternal, KPC tidak perlu dilaporkan.
Orang pertama yg melaporkan Insiden		Pilih salah satu pelapor yang paling pertama melaporkan terjadinya insiden Misal: petugas/ keluarga pasien, dll.
Insiden menyangkut pasien:		Pilih salah satu: Pasien rawat inap/Pasien rawat jalan/Pasien IGD.
Tempat/ Lokasi		Tempat pasien berada, misal ruang rawat inap, ruang rawat jalan, IGD.
Unit/ Departemen yang menyebabkan insiden		Unit/ Departemen yang menjadi penyebab terjadinya insiden, contoh: Pasien anak berobat ke poliklinik, diberikan resep, ternyata terjadi kesalahan pemberian obat oleh petugas farmasi. Hal ini diketahui setelah pasien pulang. Ibu pasien datang kembali ke Farmasi untuk menanyakan obat tersebut. Insiden: Salah pemberian obat untuk pasien anak Jenis Insiden: KNC (tidak terjadi cedera) Tempat/Lokasi: Farmasi Spesialisasi: Kasus Anak Unit penyebab : Farmasi
Akibat insiden		Pilih salah satu: (lihat tabel matriks grading risiko)
Tindakan yang dilakukan segera setelah insiden		Ceritakan penanganan/tindakan yang saat itu dilakukan agar insiden yang sama tidak terulang lagi. Tindakan dilakukan oleh Pilihlah salah satu: 1. Bila dilakukan Tim: sebutkan timnya terdiri dari siapa saja misal; dokter, perawat. 2. Bila dilakukan petugas lain: sebutkan misal; analis, asisten apoteker, apoteker

Apakah Insiden yang sama pernah terjadi di unit kerja lain	Jika Ya, lanjutkan dengan mengisi pertanyaan dibawahnya yaitu: 1. Waktu kejadian: isi dalam bulan/ tahun. Tindakan yang telah dilakukan 2. pada unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama.
--	---

7.5 Analisis Matriks Grading Risiko

Penilaian matriks risiko adalah suatu metode analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan dampak dan probabilitasnya.

- Dampak (consequences)
 Penilaian dampak/akibat suatu insiden adalah seberapa berakibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera sampai meninggal.

Tabel 12. Penilaian Dampak Klinis/ Konsekuensi/ Severity

Tingkat Risiko	Deskripsi	Dampak
1	Tidak signifikan	Tidak ada cedera
2	Minor	- Cedera ringan misal Luka lecet - Dapat diatasi dengan pertolongan pertama.
3	Moderat	- Cedera sedang mis. Luka robek - Berkurangnya fungsi motorik/ sensorik/ psikologis atau intelektual (reversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
4	Mayor	- Cedera luas/ berat misal cacat, lumpuh - Kehilangan fungsi motorik/ sensorik/ psikologis atau intelektual (irreversibel), tidak berhubungan dengan penyakit.
5	Katastropik	Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit

- Probabilitas/ frekuensi/ *likelihood*
 Penilaian tingkat probabilitas/ frekuensi risiko adalah seberapa seringnya insiden tersebut terjadi.

Tabel 13. Penilaian Probabilitas/ Frekuensi

Tingkat risiko	Probabilitas
1	Sangat jarang/ rare (>5 thn/kali)
2	Jarang/ unlikely (>2-5 thn/kali)
3	Mungkin/ possible (1-2 thn/kali)
4	Sering/ likely (bebrp kali /thn)
5	Sangat sering/ almost certain (tiap minggu/ bulan)

Setelah nilai dampak dan probabilitas diketahui, dimasukkan dalam tabel matriks grading risiko untuk menghitung skor risiko dan mencari warna *bands risiko*.

Skor Risiko :

$$\text{SKOR RISIKO} = \text{Dampak} \times \text{Probabilitas}$$

- Cara menghitung skor risiko :
- Untuk menentukan skor risiko digunakan matriks grading risiko :
- a. Tetapkan frekuensi pada kolom kiri
 - b. Tetapkan dampak pada baris ke arah kanan,
 - c. Tetapkan warna bandsnya, berdasarkan pertemuan antara frekuensi dan dampak.

Tabel 14. Matriks Grading Risiko

Probabilitas	Tidak signifikan 1	Minor 2	Moderat 3	Mayor 4	Katastropik 5
Sangat sering terjadi (tiap minggu/ bulan)	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Sering terjadi (beberapa kali/ thn)	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin terjadi (1 - <2 thn/ kali)	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Jarang terjadi (>2 - <5 thn/ kali)	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Sangat jarang terjadi (>5 thn/ kali)	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim

Keterangan:

Warna bands : hasil pertemuan antara nilai dampak yang diuru kebawah dan nilai probabilitas yang diurut ke samping kanan

Contoh :

Pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal kejadian seperti ini di rs x terjadi pada 2 tahun yang lalu

Nilai dampak : 5 (katastropik) karena pasien meninggal

Nilai probabilitas : 3 (mungkin terjadi) karena pernah terjadi 2 tahun

Lalu scoring risiko : 5 x 3 = 15 → warna bands : merah (ekstrim)

1. Bands Risiko

Bands risiko adalah derajat risiko yang digambarkan dalam empat warna yaitu : biru, hijau, kuning dan merah. Warna "bands" akan menentukan investigasi yang akan dilakukan :

Tabel 15. Tindakan Sesuai Tingkat dan Bands Risiko

Level / bands	Tindakan
Extreme (sangat tinggi)	Risiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari membutuhkan tindakan segera, perhatian sampai ke direktur,
High (tinggi)	Risiko tinggi, dilakukan rca paling lama 45 hari kaji dengan detil & perlu tindakan segera serta membutuhkan perhatian top manajemen,
Moderate (sedang)	Risiko sedang, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer/ pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelola risiko
Low (rendah)	Risiko rendah, dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin

Keterangan:
Bands biru dan hijau: investigasi sederhana oleh Apoteker Penanggung Jawab.
Bands kuning dan merah : investigasi komprehensif/ *Root Cause Analysis* (RCA) oleh Tim KP di RS.

BAB VIII

KESELAMATAN KERJA

8.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit agar terciptanya kondisi Rumah Sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman bagi sumber daya manusia Rumah Sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit perlu menerapkan SMK3 Rumah Sakit. SMK3 Rumah Sakit merupakan bagian dari sistem manajemen Rumah Sakit secara keseluruhan

8.2 Tujuan

1. Terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerjadi IFRS agar tercapai pelayanan kefarmasian dan produktivitas kerja yang optimal.

2. Memberikan perlindungan kepada pekerja farmasi, pasien, dan pengunjung.

3. Mencegah kecelakaan kerja, paparan bahan berbahaya, kebakaran dan pencemaran lingkungan.

4. Mengamankan peralatan kerja, bahan baku dan hasil produksi.

5. Menciptakan cara bekerja yang baik dan benar.

8.3 Pelaksanaan K3 IFRS

1. Identifikasi bahaya potensial.

Identifikasi bahaya potensial merupakan langkah pertama manajemen risiko kesehatan di tempat kerja. Pada tahap ini dilakukan identifikasi potensi bahaya kesehatan yang terpajan pada tenaga farmasi meliputi:

Tabel 16. Identifikasi Bahaya Potensial

NO	BAHAYA POTENSIAL	LOKASI	PEKERJAAN YANG BERISIKO
A.	KIMIA		
1.	Desinfektan.	Semua area.	Tenaga farmasi yang terpapar desinfektan.
B.	BIOLOGI		
1.	Tuberculosis.	Instalasi rawat inap dan rawat jalan, instalasi farmasi.	Tenaga farmasi saat melakukan KIE obat pasien.
C.	ERGONOMI		
1.	Pekerjaan yang dilakukan secara manual	Gudang farmasi.	Tenaga farmasi yang bertugas di gudang farmasi
2.	Postur yang salah dalam melakukan pekerjaan	Instalasi farmasi.	Tenaga farmasi.
3.	Pekerjaan yang berulang	Semua area.	Tenaga farmasi.
D.	PSIKOSOSIAL		

1.	Sering kontak dengan pasien, kerja bergilir, kerja berlebih, ancaman secara fisik.	Semua area.	Tenaga farmasi.
E.	MEKANIKAL		
1.	Terjepit mesin, tergulung, terpotong, tersayat, tertusuk.	Semua area yang terdapat peralatan mekanikal.	Tenaga farmasi.
F.	ELEKTRIKAL		
1.	Tersetrum, terbakar, ledakan.	Semua area yang terdapat arus atau instalasi listrik.	Tenaga farmasi.
H.	LIMBAH		
1	Tertumpah, tertelan, terciprat, terhirup, tertusuk.	Semua area yang menggunakan menghasilkan limbah padat, limbah cair dan limbah gas, limbah.	Tenaga farmasi.

- Pada kasus terkait dengan bahan kimia, maka perlu dipelajari *Material Safety Data Sheets* (MSDS) untuk setiap bahan kimia yang digunakan, meliputi :
1. Pengelompokan bahan kimia menurut jenis bahan aktif yang terkandung.
 2. Identifikasi bahan pelarut yang digunakan.
 3. Identifikasi bahan inert termasuk efek toksiknya.
 4. Interaksi antar bahan yang menjadi lebih berbahaya atau mungkin juga menjadi kurang berbahaya.

Beberapa pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja di Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai berikut:

Tabel 17. Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO	KEGIATAN	PENGENDALIAN RISIKO
1.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	▪ Menyiapkan dan memiliki lembar data keselamatan bahan (<i>material safety data sheet</i>). ▪ Menyiapkan sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). ▪ Pembuatan pedoman dan standar prosedur operasional pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang aman. ▪ Penanganan keadaan darurat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). ▪ Sarana keselamatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), meliputi: - Lemari Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). - Penyiram badan (<i>body wash</i>). - Pencuci mata (<i>eyewasher</i>). - Alat Pelindung Diri (APD). - Rambu dan simbol Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

		- <i>Spill kit.</i>
2.	<i>Dispensing</i> sediaan steril	▪ Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yakni jas laboratorium, masker, dan penutup kepala. ▪ Melakukan dekontaminasi dan desinfeksi dengan alkohol 70%. ▪ Pencampuran pada <i>Laminar Air Flow</i> (LAF) sesuai prosedur tetap secara aseptis. ▪ Melakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70 %. ▪ Membuang semua bekas pencampuran obat ke dalam wadah pembuangan khusus.
3.	<i>Dispensing</i> sediaan nonsteril.	▪ Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yakni masker agar tidak mengganggu saluran pernafasan. ▪ Melakukan dekontaminasi dan desinfeksi dengan alkohol 70%. ▪ Melakukan desinfeksi sarung tangan dengan alkohol 70%.
4.	KIE obat pada pasien <i>Tuberchulosis</i>	▪ Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yakni masker N95.

2. Pelayanan Kesehatan Kerja

Pelayanan Kesehatan Kerja dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan yang bersifat:

- Promotif meliputi pemenuhan gizi kerja, kebugaran, dan pembinaan mental dan rohani rutin saat *General Meeting*.
- Preventif meliputi:
 - Imunisasi (dilakukan bagi karyawan yang berisiko).
 - Pemeriksaan kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan dilakukan bagi karyawan yang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan khusus, dan pemeriksaan kesehatan pasca bekerja.
 - Surveilans lingkungan kerja dan surveilans medik.
- Kuratif meliputi pelayanan tata laksana penyakit baik penyakit menular, tidak menular, penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja, dan penanganan pasca pajanan (*post exposure profilaksis*).
- Rehabilitatif meliputi rehabilitasi medik dan program kembali bekerja (*return to work*).

BAB IX

PENINGKATAN MUTU

9.1 Prinsip

Prinsip dasar upaya peningkatan mutu pelayanan adalah pemilihan aspek yang akan ditingkatkan dengan menetapkan indikator, kriteria serta standar yang digunakan untuk mengukur mutu pelayanan Rumah Sakit.

9.2 Definisi Indikator

Indikator merupakan suatu variabel yang digunakan untuk bisa melihat perubahan. Indikator yang baik adalah yang sensitif tapi juga spesifik.

9.3 Kriteria

Spesifikasi dari indikator.

9.4 Standar

Tingkat performance atau keadaan yang dapat diterima oleh seseorang yang berwenang dalam situasi tersebut, atau oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mempertahankan tingkat performance atau kondisi tersebut. Suatu norma atau persetujuan mengenai keadaan atau prestasi yang sangat baik. Sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu. Dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan maka harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aspek yang dipilih untuk ditingkatkan
 - a. Keprofesian
 - b. Efisiensi
 - c. Keamanan dan kepuasan pasien
 - d. Sarana dan lingkungan fisik
2. Indikator yang dipilih
 - a. Indikator lebih diutamakan untuk menilai output dari pada input dan proses.
 - b. Bersifat umum, yaitu lebih baik indikator untuk situasi dan kelompok daripada untuk perorangan.
 - c. Dapat digunakan untuk membandingkan antar daerah dan antar Rumah Sakit.
 - d. Dapat mendorong intervensi sejak tahap awal pada aspek yang dipilih untuk di monitor.
 - e. Didasarkan pada data yang ada.
3. Kriteria yang digunakan

Kriteria yang digunakan harus dapat diukur dan dihitung untuk dapat menilai indikator, sehingga dapat sebagai batas yang memisahkan antara mutu baik dan mutu tidak baik.
4. Standar yang digunakan
 - a. Acuan dari berbagai sumber.
 - b. *Benchmarking* dengan Rumah Sakit yang setara.
 - c. Berdasarkan trend yang menuju kebaikan.

BAB X

PENUTUP

Buku pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi yang bekerja di rumah sakit dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang baik, efektif, dan efisien akan mendorong penggunaan obat yang rasional di rumah sakit.

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya pengobatan dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.

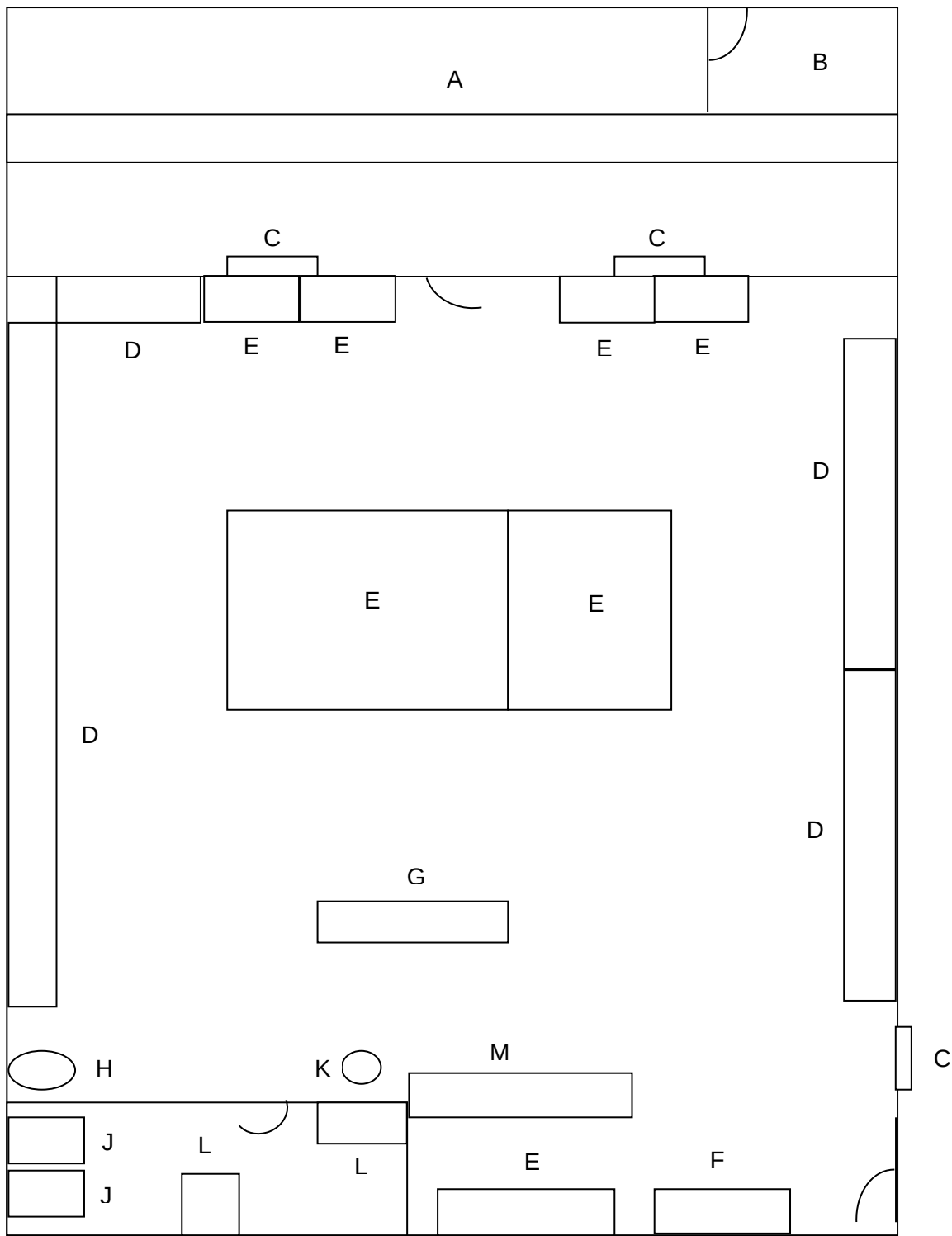
Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI

Gambar 5. Denah Ruang Depo Farmasi



- Keterangan :
- A : Meja penerimaan resep manual dan e-resep dan KIE pasien
 - B : Ruang konseling
 - C : Passbox tempat mendistribusikan obat
 - D : Rak obat
 - E : Meja kerja
 - F : Rak High Alert
 - G : Troli UDD
 - H : Wastafel
 - I : Lemari
 - J : Showcase obat

K : Dispenser untuk mencampur sediaan sirup kering
L : Lemari narkotika – psikotropika
M : Meja racik
N : Rak obat high alert, lemari B3, Rak elektrolit konsentrat tinggi